



Bunga Rampai
**PELAYANAN KESEHATAN
TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN**
DALAM PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Yohana Suganda • Hesti Ratna Sari • Sri Intan Rahayuningsih • Peny Ariani
Editor : Nadiyah Kamilia

BUNGA RAMPAI: PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Penulis:

Bd. Yohana Suganda, S.ST., M.Keb

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep

Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An

Dr. Peny Ariani, M.Keb., Bd

Editor:

Nadiyah Kamilia S.KM., M.P.H



**Bunga Rampai: Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan
dalam Praktik Tenaga Kesehatan**

Penulis:

Bd. Yohana Suganda, S.ST., M.Keb

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep

Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An

Dr. Peny Ariani, M.Keb., Bd

Editor:

Nadiyah Kamilia S.KM., M.P.H

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-89-9

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai *"Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan dalam Praktik Tenaga Kesehatan"* ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai salah satu kontribusi ilmiah bagi penguatan mutu layanan kesehatan di berbagai tatanan pelayanan.

Pelayanan kesehatan saat ini menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada tindakan kuratif, tetapi juga mengedepankan kesinambungan layanan dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Konsep pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan (*continuum of care*) menjadi fondasi penting agar pasien memperoleh layanan yang utuh, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan sepanjang daur kehidupan. Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan—terutama di layanan primer menjadi kunci dalam memastikan keterhubungan antar layanan, antar profesi, dan antar tingkat fasilitas kesehatan.

Bunga rampai ini disusun dengan memuat topik-topik strategis yang saling melengkapi. Bab tentang konsep pelayanan terpadu dan berkesinambungan menghadirkan landasan pemahaman mengenai pentingnya integrasi layanan, koordinasi rujukan, serta kesinambungan asuhan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemetaan kebutuhan informasi

kesehatan wanita sub remaja dan platform yang sering digunakan menyoroti urgensi literasi kesehatan sejak dini, termasuk pemanfaatan media dan platform digital yang relevan dengan karakteristik usia, budaya, dan kebiasaan akses informasi. Topik ini penting agar edukasi kesehatan dapat tersampaikan secara tepat, aman, dan berdampak.

Buku ini juga mengangkat peran perawat dalam asuhan keperawatan holistik, yang menegaskan bahwa keberhasilan layanan berkesinambungan tidak terlepas dari kemampuan perawat melihat pasien sebagai individu yang utuh meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual serta memastikan asuhan berjalan konsisten dari satu tahap ke tahap berikutnya. Terakhir, bab mengenai tantangan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer memberikan gambaran nyata tentang dinamika di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja, sistem rujukan, hingga kebutuhan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh konsep, tetapi juga refleksi praktis atas hambatan dan peluang perbaikan.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi, serta pemantik diskusi bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, akademisi, dan para pemangku kebijakan untuk terus memperkuat layanan kesehatan yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan bunga rampai ini. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Maret 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

CHAPTER 1 KONSEP PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN (*CONTINUUM OF CARE*)..... 1

Bd. Yohana Suganda, S.ST., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Filosofi Continuum of Care	3
C. Dimensi Utama Continuum of Care.....	4
D. Komponen Kesinambungan Asuhan.....	6
E. Strategi Implementasi di Indonesia	8
F. Tantangan dalam Pelaksanaan Continuum of Care	10
G. Referensi.....	12
H. Glosarium.....	13

CHAPTER 2 PEMETAAN KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN WANITA SUB REMAJA DAN PLATFORM YANG SERING DIGUNAKAN 14

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.	14
A. Pendahuluan/Prolog.....	14
B. Konsep Dasar Masa Remaja	15
C. Karakteristik Masa Remaja	16
D. Perkembangan emosi pada masa remaja	20

E. Perkembangan intelegensi dan kognitif pada masa remaja	21
F. Dinamika Seksualitas Pada Masa Remaja.....	23
G. Masalah dan Risiko Kesehatan Reproduksi pada Remaja	25
H. Tinjauan Pustaka (Media Sosial dan Teori)	29
I. Platform media yang sering digunakan	33
J. Simpulan	37
K. Referensi.....	37

CHAPTER 3 PERAN PERAWAT DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HOLISTIK..... 40

Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An.....	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Holistik.....	42
C. Tantangan dalam Penerapan Asuhan Keperawatan Holistik	51
D. Hambatan dalam Pelayanan Kesehatan yang holistik....	59
E. Simpulan	62
F. Referensi.....	63
G. Glosarium.....	69

CHAPTER 4 TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER 70

Dr. Peny Ariani, M.Keb., Bd.	70
A. Pendahuluan.....	70
B. Konsep Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan	72
C. Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan Primer.....	74
D. Pelayanan Terpadu dan Berkesinambungan.....	76
E. Peta Tantangan Pelayanan di Fasilitas Primer.....	81

F. Dampak Tantangan terhadap Layanan	95
G. Strategi Solusi Berbasis “Terpadu & Berkesinambungan”	100
H. Kesimpulan.....	108
I. Referensi.....	110
J. Glosarium.....	115
PROFIL PENULIS	125

CHAPTER 1

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN (*CONTINUUM OF CARE*)

Bd. Yohana Suganda, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan modern kini bergeser dari penanganan penyakit secara parsial menuju pelayanan yang holistik dan terintegrasi. Salah satu paradigma kunci dalam transformasi ini adalah konsep Continuum of Care (CoC) atau pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Menurut World Health Organization (WHO), pendekatan ini merupakan strategi krusial untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pemberian asuhan yang tidak terputus sepanjang siklus hidup, mulai dari masa pra-hamil hingga masa tua.

Sistem kesehatan modern saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengatasi fragmentasi layanan yang seringkali menyebabkan penurunan kualitas asuhan dan peningkatan biaya kesehatan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, konsep Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan atau Continuum of Care (CoC) menjadi paradigma yang diakui secara internasional. Menurut World Health Organization (WHO, 2023),

Continuum of Care adalah pendekatan yang memberikan layanan kesehatan tanpa terputus, mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga kesehatan anak dan lansia. Pendekatan ini sangat krusial dalam upaya global untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan sebuah negara.

Di Indonesia, implementasi asuhan berkelanjutan ini menjadi ruh dalam kebijakan Transformasi Kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (2024), pelayanan terpadu dilaksanakan melalui penguatan layanan primer yang mengintegrasikan berbagai siklus hidup manusia dalam satu ekosistem layanan yang terstandar. Konsep ini memiliki dua dimensi utama: dimensi waktu (kesinambungan layanan sesuai tahapan usia) dan dimensi tempat (koordinasi yang kuat antara perawatan di rumah, komunitas/Puskesmas, hingga rumah sakit rujukan). Tanpa adanya integrasi yang baik antar-tingkat layanan ini, pasien berisiko kehilangan akses terhadap intervensi medis yang dibutuhkan tepat pada waktunya.

Keberhasilan Continuum of Care tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Sebagaimana dijelaskan oleh Astuti dkk. (2017), kesinambungan asuhan mencakup tiga aspek penting: kesinambungan relasi (kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan), kesinambungan informasi (pencatatan medis

yang terintegrasi), dan kesinambungan manajemen (alur rujukan yang efisien). Melalui model ini, pasien tidak lagi dipandang sebagai objek pengobatan sesaat, melainkan sebagai individu yang didampingi secara berkelanjutan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal sepanjang hayat.

B. Definisi dan Filosofi Continuum of Care

Secara terminologi, Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan atau Continuum of Care (CoC) didefinisikan sebagai sebuah sistem pelayanan yang memastikan individu mendapatkan asuhan kesehatan secara berkelanjutan tanpa terputus sepanjang tahapan kehidupannya. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), CoC bukan sekadar pemberian layanan medis, melainkan sebuah struktur organisasi yang mengintegrasikan berbagai intervensi kesehatan mulai dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan kesehatan anak. Di Indonesia, definisi ini diperluas oleh Kementerian Kesehatan RI (2024) sebagai rangkaian pelayanan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia, di mana setiap fase perkembangan individu mendapatkan pengawasan medis yang terstandar guna mencegah terjadinya risiko kesehatan yang fatal.

Filosofi dasar dari Continuum of Care berpijak pada keyakinan bahwa kesehatan adalah sebuah proses linear yang saling berkaitan, bukan kumpulan kejadian medis yang berdiri sendiri. Astuti dkk. (2017) menjelaskan bahwa filosofi CoC menekankan pada pentingnya hubungan jangka

panjang antara tenaga kesehatan dan pasien yang didasarkan pada rasa saling percaya (partnership). Dalam pandangan ini, asuhan tidak lagi berfokus pada "penyakit" semata (illness-centered), melainkan berpusat pada "orang" (person-centered) dan kebutuhan holistiknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman asuhan yang manusiawi, di mana pasien merasa didampingi secara konsisten oleh penyedia layanan yang memahami riwayat kesehatan mereka secara utuh.

Lebih lanjut, filosofi CoC mengintegrasikan dua dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat. Berdasarkan kerangka kerja Kerber dkk. (2007), filosofi ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara perawatan mandiri di tingkat rumah tangga, layanan komunitas seperti Puskesmas, hingga fasilitas rujukan tingkat lanjut di rumah sakit. Esensi dari filosofi ini adalah "konektivitas"; bahwa keberhasilan intervensi di satu tahap (misalnya asuhan antenatal) akan sangat menentukan keberhasilan di tahap berikutnya (persalinan dan kesehatan bayi). Dengan demikian, CoC menjadi fondasi untuk meminimalkan celah dalam sistem kesehatan yang sering kali menyebabkan kegagalan penanganan medis akibat buruknya koordinasi antar-fasilitas.

C. Dimensi Utama Continuum of Care

Implementasi Continuum of Care (CoC) didasarkan pada dua dimensi strategis yang saling beririsan untuk menjamin kualitas asuhan yang komprehensif. Dimensi

pertama adalah dimensi waktu (outreach from pre-pregnancy to childhood and beyond), yang menekankan pada pemberian layanan kesehatan sesuai dengan urutan siklus hidup individu. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), dimensi waktu ini sangat kritikal karena kegagalan asuhan pada satu fase, seperti masa kehamilan, akan berdampak langsung pada risiko komplikasi di masa persalinan dan kesehatan bayi baru lahir. Fokus utama dari dimensi ini adalah menjamin transisi asuhan yang mulus sehingga tidak ada celah layanan (gap) saat individu berpindah dari satu fase perkembangan ke fase berikutnya (Kerber dkk., 2017).

Dimensi kedua adalah dimensi tempat (linkages antara berbagai tingkat pelayanan), yang menghubungkan berbagai tingkatan fasilitas kesehatan mulai dari tingkat rumah tangga hingga rumah sakit rujukan. Kementerian Kesehatan RI (2024) menegaskan bahwa dimensi tempat dalam CoC di Indonesia diwujudkan melalui penguatan koordinasi antara perawatan mandiri di keluarga, layanan di komunitas seperti Posyandu, pelayanan primer di Puskesmas, hingga pelayanan spesialis di Rumah Sakit. Sinergi antar-tempat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan tingkat perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya tanpa harus mengalami hambatan birokrasi atau kehilangan informasi medis selama proses rujukan (Astuti dkk., 2017).

Selain dimensi waktu dan tempat, terdapat pula dimensi kesinambungan asuhan yang bersifat kualitatif

untuk memperkuat efektivitas CoC. Menurut Haggerty dkk. (2013), sebagaimana dikutip dalam Poltekkes Kemenkes (2023), kesinambungan ini mencakup tiga pilar utama: kesinambungan informasi (ketersediaan rekam medis yang terintegrasi), kesinambungan manajemen (protokol klinis yang konsisten antar-tenaga kesehatan), dan kesinambungan relasi (terjaganya hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan). Integrasi ketiga pilar ini dalam dimensi waktu dan tempat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang benar-benar berpusat pada pasien dan mampu memberikan hasil kesehatan yang optimal sepanjang hayat.

Menurut kerangka kerja yang dikembangkan oleh The Lancet (2017) dan diadopsi secara global, CoC terdiri dari dua dimensi yang saling beririsan:

1. Dimensi Waktu (Time): Kesinambungan layanan sesuai dengan tahapan siklus hidup manusia. Fokus utamanya adalah memastikan transisi yang mulus dari asuhan antenatal ke asuhan persalinan dan pasca-persalinan.
2. Dimensi Tempat (Space/Level of Care): Integrasi layanan antara lingkungan rumah tangga (mandiri), masyarakat (UKBM/Posyandu), pelayanan primer (Puskesmas/Klinik), hingga pelayanan sekunder/tersier (Rumah Sakit).

D. Komponen Kesinambungan Asuhan

Efektivitas dari Continuum of Care (CoC) sangat bergantung pada pemenuhan tiga komponen utama kesinambungan asuhan yang saling berinteraksi. Komponen

pertama adalah kesinambungan informasi (informational continuity), yang merujuk pada penggunaan informasi dari peristiwa medis masa lalu untuk memberikan asuhan yang tepat bagi pasien di masa kini. Menurut Haggerty dkk. (2003), sebagaimana diulas kembali dalam literatur Poltekkes Kemenkes (2023), kesinambungan informasi memastikan bahwa riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan laboratorium, dan preferensi pasien tersedia bagi setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam rantai pelayanan, sehingga mencegah terjadinya kesalahan medis atau pengulangan prosedur yang tidak perlu.

Komponen kedua adalah kesinambungan manajemen (management continuity), yang berfokus pada pendekatan asuhan yang selaras dan saling melengkapi antar-tenaga kesehatan. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO, 2023), kesinambungan ini sangat penting dalam penanganan kondisi kompleks yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (kolaborasi interprofesional). Melalui protokol klinis yang terstandar dan koordinasi rujukan yang efektif, pasien dapat berpindah antar-level fasilitas kesehatan—dari layanan primer ke rumah sakit rujukan—dengan transisi yang terorganisir dan tidak membingungkan bagi pasien maupun keluarganya (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Komponen ketiga, yang sering dianggap sebagai jantung dari CoC, adalah kesinambungan relasi (relational continuity). Komponen ini menekankan pada pentingnya hubungan terapeutik yang berkelanjutan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang konsisten secara personal.

Astuti dkk. (2017) menjelaskan bahwa kesinambungan relasi membangun rasa aman dan kepercayaan yang lebih dalam pada pasien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap saran medis dan mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan kesehatan secara jangka panjang. Integrasi ketiga komponen ini—informasi yang akurat, manajemen yang terkoordinasi, dan relasi yang kuat—merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai asuhan yang berkualitas dan berpusat pada pasien.

Agar pelayanan dapat dikatakan "berkesinambungan", terdapat tiga aspek kunci yang harus dipenuhi (Haggerty dkk., dalam Poltekkes Kemenkes, 2023):

1. **Kesinambungan Relasi (Relational Continuity):** Adanya hubungan terapeutik yang konsisten antara pasien dan tenaga kesehatan (seperti model "Satu Bidan Satu Ibu"). Hal ini membangun kepercayaan dan kepatuhan pasien.
2. **Kesinambungan Informasi (Informational Continuity):** Penggunaan data medis (rekam medis) yang dapat diakses di berbagai level layanan sehingga riwayat pasien tidak terputus.

Kesinambungan Manajemen (Management Continuity): Koordinasi asuhan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (kolaborasi interprofesional) melalui sistem rujukan yang terstandar.

E. Strategi Implementasi di Indonesia

Strategi implementasi Continuum of Care (CoC) di Indonesia saat ini berfokus pada penguatan layanan primer sebagai fondasi utama melalui kebijakan Transformasi Kesehatan. Berdasarkan cetak biru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI (2024), strategi ini diwujudkan melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang mengubah paradigma pelayanan dari berbasis penyakit menjadi pelayanan berbasis kluster siklus hidup. Dalam model ini, Puskesmas dan Posyandu tidak lagi bekerja secara terfragmentasi, melainkan memberikan layanan yang terintegrasi mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga lansia dalam satu alur koordinasi yang sistematis guna memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan akses kesehatan.

Aspek krusial lainnya dalam strategi implementasi di Indonesia adalah akselerasi digitalisasi sistem informasi kesehatan untuk menjamin kesinambungan data pasien. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2023), peluncuran platform SATUSEHAT menjadi terobosan utama dalam memfasilitasi informational continuity di seluruh pelosok negeri. Dengan integrasi rekam medis elektronik (RME) yang diwajibkan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, data medis pasien kini dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan di berbagai tingkatan layanan, mulai dari klinik pratama hingga rumah sakit rujukan tipe A. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan diagnosa dan mempercepat proses rujukan medis yang selama ini sering terhambat oleh kendala birokrasi data.

Selain penguatan sistem dan teknologi, strategi ini juga menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi interprofesional. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Poltekkes Kemenkes (2023), implementasi CoC di lapangan sangat bergantung pada peran aktif bidan desa dan kader kesehatan dalam melakukan pendampingan keluarga (perawatan di tingkat rumah tangga). Upaya ini didukung oleh regulasi yang mendorong kolaborasi antar-tenaga kesehatan—seperti dokter, perawat, dan ahli gizi—melalui pembentukan tim kerja yang solid di tingkat Puskesmas. Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, dan komitmen tenaga kesehatan di lapangan, Indonesia berupaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih responsif dan berkesinambungan bagi seluruh warga negara (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Transformasi Kesehatan (2022-2024) mengedepankan integrasi layanan primer sebagai motor utama CoC.

1. Penerapan Siklus Hidup: Pelayanan kesehatan di Puskesmas kini tidak lagi berbasis poli penyakit, melainkan berbasis kluster siklus hidup (Kluster Ibu & Anak, Kluster Usia Dewasa & Lansia).
2. Digitalisasi Kesehatan: Penggunaan platform SATUSEHAT (Kemenkes RI, 2024) menjadi tulang punggung informational continuity yang memungkinkan rekam medis elektronik terintegrasi secara nasional.

F. Tantangan dalam Pelaksanaan Continuum of Care

Meskipun konsep *Continuum of Care* (CoC) menawarkan solusi ideal bagi sistem kesehatan, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan fragmentasi sistem rujukan. Menurut World Health Organization (WHO, 2023), tantangan utama secara global adalah kurangnya koordinasi antar-fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien sering kali kehilangan kesinambungan asuhan saat berpindah dari layanan primer ke sekunder. Di Indonesia, hal ini diperparah oleh kendala geografis dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, di mana daerah terpencil masih kesulitan mengakses layanan spesialis yang terintegrasi, sehingga memutus rantai asuhan yang seharusnya berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Tantangan kedua berkaitan dengan aspek teknis dan manajerial, khususnya dalam hal interoperabilitas data kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan Kementerian Kesehatan RI (2023), meskipun platform SATUSEHAT telah diluncurkan, masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan di daerah yang menghadapi kendala infrastruktur digital dan literasi teknologi bagi tenaga medis. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis elektronik (RME) mengakibatkan terputusnya informational continuity, di mana dokter di rumah sakit rujukan tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai asuhan yang telah diberikan di tingkat Puskesmas. Hal ini berisiko menimbulkan pengulangan pemeriksaan yang tidak efisien dan potensi kesalahan medis akibat informasi yang tidak sinkron.

Selain faktor sistem dan teknologi, tantangan budaya organisasi dan ego sektoral antar-profesi kesehatan juga menjadi hambatan yang nyata. Berdasarkan tinjauan literatur Astuti dkk. (2017) dan diperkuat oleh studi dalam Poltekkes Kemenkes (2023), keberhasilan CoC sangat bergantung pada kolaborasi interprofesional yang setara. Namun, dalam praktiknya, sering kali masih terdapat dominasi profesi tertentu atau kurangnya komunikasi efektif antara bidan, dokter, dan perawat. Beban kerja yang tinggi (overload) di fasilitas kesehatan juga sering kali memaksa tenaga kesehatan untuk fokus pada aspek kuratif jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek relational continuity yang sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan pasien.

G. Referensi

- Astuti, S., Judistiani, R. T. D., Rahmiati, L., & Susanti, A. I. (2017). *Asuhan Kebidanan Secara Continuity of Care (CoC): Pengantar dan Teori*. Yogyakarta: PT. Cahaya Bangsa.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Pedoman Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kerber, K. J., de Graft-Johnson, J. E., Bhutta, Z. A., Okong, P., Starrs, A., & Lawn, J. E. (2007). Continuum of Care for Maternal, Newborn, and Child Health: From Slogan to Service Delivery. *The Lancet*, 370(9595), 1358-1369.

- Kerber, K. J., dkk. (2007). Continuum of Care for Maternal, Newborn, and Child Health: From Slogan to Service Delivery. *The Lancet*, 370(9595), 1358-1369.
- Poltekkes Kemenkes. (2023). Buku Ajar: Konsep Dasar Kebidanan dan Continuity of Care (CoC). Medan: Unit Publikasi Ilmiah.
- Poltekkes Kemenkes. (2023). Modul Konsep Dasar Kebidanan dan Continuity of Care. Medan: Unit Publikasi Ilmiah.
- Reid, R., dkk. (2021). The Value of Continuity of Care in the Context of Health System Transformation. *Journal of Health Services Research & Policy*.
- Reid, R., dkk. (2021). The Value of Continuity of Care in the Context of Health System Transformation. *Journal of Health Services Research & Policy*.
- World Health Organization (WHO). (2023). Improving Maternal and Newborn Health and Survival and Reducing Stillbirth. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2023). Universal Health Coverage and the Continuity of Care Framework. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2023). Universal Health Coverage and the Continuity of Care Framework. Geneva: WHO Press.

H. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 2

PEMETAAN KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN WANITA SUB REMAJA DAN PLATFORM YANG SERING DIGUNAKAN

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Media sosial menjadi sebuah bukti kemajuan teknologi saat ini dimana kita dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lainnya. Terdapat beberapa tampilan dari media sosial yaitu gambar, teks, audio, video, dan lainnya. Adapun macam-macam dari media sosial yaitu Instagram, tiktok, whatsapp, youtube, twitter, dan lainnya. Media sosial memiliki beberapa manfaat kepada para penggunanya seperti memudahkan dalam berkomunikasi tanpa batas, dapat menikmati konten menarik yang dihasilkan media sosial, meningkatkan pengetahuan akan informasi yang dihasilkan, dan manfaat lainnya. Media sosial menghilangkan batasan yang ada sehingga pengguna media sosial dapat dengan mudah mendapatkan berita atau informasi yang dibutuhkan. Berangkat dari minat pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan pada media sosial, tentunya media sosial harus mempunyai informasi yang layak, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat terpenuhi kebutuhan informasinya untuk

semua kalangan mulai balita, anak Remaja, dewasa dan lanjut usia.

Remaja, dengan segala karakteristik dan tugas perkembangannyapun tidak dapat lepas dari berbagai bentuk fasilitas yang ada pada internet Remaja dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan beresiko terkena dampak dari internet. Para ahli sepakat bahwa penggunaan internet layak untuk mendapatkan perhatian serius mengingat penggunaan internet pada remaja ada kecenderungan semakin hari semakin meningkat dan cenderung berlebihan, dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan adanya gangguan mental seperti gangguan anti sosial, gangguan kecemasan, dan gangguan stress pada penggunanya (Taylor, 2009 dikutip Yudaningsgar, 2023).

B. Konsep Dasar Masa Remaja

Masa remaja merupakan fase perkembangan penting dalam kehidupan manusia yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Menurut Saryono & Wulandari (2018), masa remaja ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, sosial, dan moral yang terjadi secara cepat dan kompleks. Pada tahap ini, individu mulai menunjukkan kematangan organ reproduksi, berpikir lebih abstrak, dan mulai mencari identitas diri.

Menurut Prawirohardjo (2019), masa remaja dimulai sekitar usia 10–19 tahun, sesuai dengan batasan dari WHO. Pada masa ini terjadi perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan munculnya ciri-ciri

seksual sekunder. Selain itu, remaja juga mulai menunjukkan perkembangan kognitif dan emosional yang signifikan, seperti kemampuan berpikir kritis, munculnya perasaan cinta, dan keinginan untuk diakui sebagai individu yang mandiri.

Secara umum, masa remaja adalah masa yang penuh dengan dinamika dan pencarian jati diri. Remaja mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan peran sosial baru, mengambil keputusan sendiri, dan membentuk nilai-nilai moral yang akan menjadi dasar kehidupannya di masa dewasa.

C. Karakteristik Masa Remaja

Seiring dengan pemahaman tentang konsep dasar masa remaja tersebut, penting pula untuk mengenali karakteristik yang muncul pada setiap individu di masa ini. Karakteristik-karakteristik tersebut membantu tenaga kesehatan memahami perubahan menyeluruh yang dialami remaja, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Karakteristik masa remaja dapat dilihat dari berbagai aspek perkembangan, antara lain:

1. Perkembangan Fisik

Menurut LAURA E. BERK, 2022 perkembangan fisik Remaja meliputi:

Untuk organ Reproduksi akan diawali dengan adanya pubertas perempuan biasanya dimulai dengan tumbuhnya payudara dan percepatan pertumbuhan. Menarche, atau menstruasi pertama, biasanya terjadi sekitar usia 12½ tahun untuk perempuan Amerika Utara,

13 tahun untuk perempuan Eropa Barat. Namun rentang usianya cukup luas, dari 10½ hingga 15½ tahun. Setelah menarche, pertumbuhan payudara dan rambut kemaluan selesai, dan rambut ketiak muncul. bahwa alam menunda kematangan seksual hingga tubuh perempuan cukup besar untuk melahirkan; menarche terjadi setelah puncak percepatan pertumbuhan tinggi badan. Sebagai tindakan pengamanan tambahan, selama 12 hingga 18 bulan setelah menarche, siklus menstruasi sering terjadi tanpa pelepasan sel telur dari ovarium (Fuqua & Rogol, 2013). Namun periode sterilitas sementara ini tidak terjadi pada semua perempuan, dan tidak memberikan perlindungan yang andal terhadap kehamilan.

Transformasi fisik pada masa remaja mencakup perubahan besar pada otak. Penelitian pencitraan otak mengungkapkan pemangkasan sinapsis yang tidak digunakan secara terus-menerus di korteks serebral, terutama korteks prefrontal. Pertumbuhan dan mielinisasi serat saraf yang terstimulasi semakin cepat, memperkuat koneksi antar berbagai wilayah otak. Secara khusus, hubungan antara korteks prefrontal dan area lain di korteks serebral dan otak bagian dalam (termasuk amigdala dan hipokampus) meluas dan mencapai komunikasi yang cepat. Akibatnya, remaja memperoleh peningkatan dalam beragam keterampilan kognitif, termasuk fungsi eksekutif, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

Namun, kemajuan dalam kontrol kognitif ini terjadi secara bertahap selama masa remaja. Bukti MRI mengungkapkan bahwa remaja merekrut jaringan koneksi korteks prefrontal dengan area otak lainnya kurang efektif dibandingkan orang dewasa. Karena jaringan kontrol kognitif prefrontal masih membutuhkan penyesuaian, kinerja remaja pada tugas-tugas yang membutuhkan inhibisi, perencanaan, dan penundaan gratifikasi (menolak hadiah langsung yang lebih kecil demi hadiah yang lebih besar di kemudian hari) belum sepenuhnya matang. Ditambah dengan kesulitan fungsi eksekutif dan pengaturan diri ini adalah perubahan dalam jaringan emosional/sosial otak. Saat manusia dan mamalia lain menjadi dewasa secara seksual, neuron menjadi lebih responsif terhadap neurotransmitter eksitatori.

Akibatnya, remaja bereaksi lebih kuat terhadap peristiwa yang menegangkan dan mengalami rangsangan yang menyenangkan dengan lebih intens. Perubahan dalam jaringan emosional/sosial juga meningkatkan sensitivitas remaja terhadap rangsangan sosial, membuat mereka sangat reaktif terhadap pengaruh dan evaluasi teman sebaya. Karena jaringan kontrol kognitif belum berfungsi secara optimal, sebagian besar remaja merasa sangat sulit untuk mengelola perasaan dan impuls yang kuat. Ketidakseimbangan ini berkontribusi pada dorongan remaja yang tak terkendali untuk pengalaman baru, termasuk penggunaan narkoba, mengemudi sembrono, seks tanpa perlindungan, dan aktivitas kenakalan. Dalam

sebuah studi longitudinal terhadap sampel besar dan representatif dari remaja AS, para peneliti melacak perubahan dalam impulsivitas dan pencarian sensasi yang dilaporkan sendiri antara usia 12 dan 24 tahun, impulsivitas menurun secara stabil seiring bertambahnya usia—bukti perbaikan bertahap.

2. Perkembangan Psikologis

Menurut Kusumawati (2022), remaja mulai membangun konsep diri dan mencari identitas personal. Mereka berusaha memahami siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Masa ini sering ditandai dengan konflik batin antara keinginan untuk mandiri dengan kebutuhan akan dukungan orang tua.

3. Perkembangan Emosional

Remaja cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Mereka mudah tersinggung, cepat marah, dan cenderung bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon dan perkembangan otak bagian prefrontal yang belum matang sepenuhnya.

4. Perkembangan Sosial

Remaja mulai menjalin hubungan yang lebih luas di luar keluarga, terutama dengan teman sebaya. Pengaruh kelompok teman sebaya (peer group) sangat kuat dan dapat membentuk perilaku, nilai, serta gaya hidup mereka.

5. Perkembangan Moral dan Spiritual

Remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil dan membentuk sistem moralnya sendiri. Mereka juga mulai memahami makna spiritualitas dan nilai keagamaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

D. Perkembangan emosi pada masa remaja

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa dimana ketegangan emosi meningkat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pertumbuhan pada tahun – tahun awal masa puber terus berlangsung tetapi berjalan agak lambat. Pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat melengkapi pola yang sudah terbentuk pada masa puber. Oleh karena itu, perlu dicari keterangan lain yang menjelaskan ketegangan emosi yang sangat khas pada usia ini. Sikap, perasaan atau emosi seseorang telah ada dan berkembang semenjak ia bergal dengan lingkungannya. Timbulnya sikap, perasaan atau emosi itu (positif atau negatif) merupakan produk pengamatan dari pengalaman individu secara unik dengan benda-benda fisik lingkungannya, dengan orang tua dan saudara-saudara, serta pergaulan sosial yang lebih luas. Sebagai suatu produk dari lingkungan (lingkungan internal dan eksternal) yang juga berkembang, maka sudah tentu sikap, perasaan/emosi itu juga berkembang. Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri-hati, sedih, gembira, kasih sayang dan ingin tahu. Dalam hal emosi

yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik. Sebagai remaja dalam bertingkah laku sangat dikuasai oleh emosinya. Elizabeth B. Hurlock berpendapat bahwa: Pemuda remaja dapat menghilangkan “unek-unek” atau kekuatan-kekuatan yang ditimbulkan oleh emosi yang ada dengan cara mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan emosi-emosi itu dengan seseorang yang dipercayainya. Menghilangkan kekuatan-kekuatan emosi terpendam tersebut disebut juga “emotional catharsis

Cara-cara yang dapat ditempuh dalam usaha menemukan dan membongkar kekuatan emosi yang terpendam itu dapat dilakukan dengan cara bermain, bekerja, dan lebih baik lagi adalah dengan mengatakannya kepada seorang yang dapat menunjukkan gambaran masalah-masalah yang dihadapi remaja yang bersangkutan. Peranan pendidik, guru terutama konselor sangat penting dalam hal ini, sebab mereka dapat melakukannya dengan penerimaan dan pemahaman dalam membantu kegiatan “emotional catharsis” tersebut

E. Perkembangan intelegensi dan kognitif pada masa remaja

Remaja adalah suatu periode kehidupan dimana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Disamping itu, masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf frontal lobe. Frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi. Perkembangan frontal lobe tersebut

sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Kemudian, dalam kekuatan baru dalam penalaran yang dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan.

1. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget Ditinjau dari prespektif teori kognitif Piaget: Maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira – kira antara 11 – 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. 7 Disamping itu, remaja pada masa ini juga mampu berpikir secara sistematis, mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan.
2. Perkembangan pengambilan keputusan Remaja adalah masa dimana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mulai mengambil keputusan – keputusan tentang masa depan, memilih teman, dll. Dalam hal pengambilan keputusan ini, remaja lebih tua ternyata lebih kompeten dibanding anak – anak. Apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda mempunyai kemampuan yang kurang dalam ketrampilan pengambilan keputusan. Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan – keputusan salah oleh orientasi masyarakat.

3. Perkembangan kognisi sosial Menurut Dacey dan Kenny, yang dimaksud dengan kognisi sosial adalah: Kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu – isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang dalam usia dan sejalan dengan pengalaman serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Menurut sejumlah ahli psikologi perkembangan, ketrampilan – ketrampilan kognitif yang muncul pada masa remaja ini mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan kognisi sosial mereka. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan aspek kognisi sosial remaja ini adalah apa yang diistilahkan oleh Psikolog David Elkind dengan “egosentrisme, yaitu kecenderungan remaja untuk menerima dunia. Mereka menganggap semua mata terpaku pada penampilannya.”

F. Dinamika Seksualitas Pada Masa Remaja

Seksualitas pada masa remaja merupakan bagian dari perkembangan manusia yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan moral. Seksualitas tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual, tetapi juga dengan identitas gender, peran sosial, dan kemampuan menjalin hubungan yang sehat.

Menurut Saryono & Wulandari (2018), pemahaman seksualitas yang baik membantu remaja mengenal tubuhnya, menghargai diri sendiri, dan memahami tanggung jawab terhadap perilaku seksual. Sebaliknya, kurangnya informasi

yang tepat dapat menimbulkan perilaku berisiko seperti hubungan seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, dan infeksi menular seksual.

Beberapa aspek penting dalam dinamika seksualitas remaja meliputi:

1. Aspek Biologis
 - a. Terjadinya pubertas yang memunculkan fungsi reproduksi.
 - b. Muncul dorongan seksual akibat peningkatan hormon estrogen dan testosteron.
 - c. Kesadaran terhadap perubahan tubuh mulai tumbuh, sehingga muncul rasa ingin tahu terhadap lawan jenis.
2. Aspek Psikologis
 - a. Remaja mulai memahami orientasi dan identitas seksualnya.
 - b. Munculnya ketertarikan emosional dan romantis terhadap orang lain.
 - c. Terdapat konflik antara keinginan pribadi dengan nilai sosial dan agama.
3. Aspek Sosial dan Budaya
 - a. Lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media massa sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap seksual remaja.
 - b. Norma budaya menentukan batas-batas perilaku seksual yang dapat diterima di masyarakat.
4. Aspek Moral dan Spiritual
 - a. Nilai agama dan etika menjadi panduan bagi remaja dalam mengontrol dorongan seksual.

- b. Pendidikan moral membantu membentuk tanggung jawab dalam bersikap terhadap lawan jenis.

Menurut Kusumawati (2022), pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sesuai usia sangat penting untuk membantu remaja memahami tubuh dan perilakunya secara benar. Pendidikan ini tidak hanya mencegah perilaku menyimpang, tetapi juga menumbuhkan sikap positif terhadap kesehatan reproduksi dan hubungan interpersonal yang sehat

G. Masalah dan Risiko Kesehatan Reproduksi pada Remaja

Masa remaja merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sangat cepat. Perubahan tersebut menyebabkan remaja berada pada fase pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kondisi ini menjadikan remaja rentan terhadap berbagai masalah dan risiko kesehatan reproduksi apabila tidak dibekali dengan pemahaman serta pengendalian diri yang baik.

Menurut Natosba dkk. (2023) dalam *Buku Ajar Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, terdapat beberapa masalah dan risiko kesehatan reproduksi yang umum terjadi pada masa remaja, di antaranya meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja merupakan salah satu masalah serius dalam kesehatan reproduksi. Remaja yang belum memiliki kesiapan fisik maupun mental berisiko mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia, perdarahan, kelahiran prematur, serta risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Selain itu, KTD juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti tekanan mental, putus sekolah, hingga stigma negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini biasanya terjadi akibat kurangnya pendidikan seksual, penggunaan kontrasepsi yang salah, serta dorongan emosi yang tidak terkendali.

2. Perilaku Seksual Berisiko

Remaja sering kali melakukan eksplorasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual tanpa memahami risiko yang ditimbulkan. Perilaku seksual berisiko meliputi hubungan seksual pranikah, berganti-ganti pasangan, serta tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom. Akibatnya, remaja berpotensi tertular infeksi menular seksual (IMS) seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan klamidia. Menurut Natosba dkk. (2023), faktor penyebab perilaku seksual berisiko antara lain pengaruh teman sebaya, paparan media yang tidak mendidik, serta rendahnya pengawasan dari orang tua.

3. Infeksi Menular Seksual (IMS)

IMS menjadi salah satu risiko utama akibat perilaku seksual tidak aman. Remaja sering kali tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi karena gejala yang muncul cenderung ringan atau tidak tampak. Penularan dapat

terjadi melalui hubungan seksual vaginal, oral, maupun anal tanpa pengaman. Dampak jangka panjang IMS dapat mengganggu fungsi organ reproduksi, menyebabkan kemandulan, dan meningkatkan risiko kanker serviks. Pencegahan dapat dilakukan dengan perilaku seksual yang bertanggung jawab dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja.

4. Kekerasan Seksual

Remaja, khususnya perempuan, berisiko menjadi korban kekerasan seksual baik dalam bentuk pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, maupun eksploitasi melalui media digital. Kekerasan seksual dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental korban, seperti trauma psikologis, depresi, hingga gangguan kecemasan. Natosba dkk. (2023) menekankan pentingnya pendidikan seksualitas berbasis nilai dan penguatan karakter agar remaja mampu menolak dan melindungi diri dari kekerasan seksual.

5. Gangguan Citra Tubuh dan Psikologis

Perubahan bentuk tubuh yang cepat selama masa pubertas sering menimbulkan ketidakpuasan terhadap penampilan. Remaja yang tidak siap menghadapi perubahan ini dapat mengalami gangguan citra tubuh, rendah diri, bahkan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Selain itu, tekanan sosial dan budaya terhadap standar kecantikan juga memperburuk kondisi psikologis remaja.

6. Penyalahgunaan NAPZA dan Pengaruh terhadap Reproduksi

Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Zat-zat tersebut dapat menurunkan kualitas sperma dan ovum, mengganggu keseimbangan hormon, serta meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko. Natosba dkk. (2023) menjelaskan bahwa penyalahgunaan NAPZA juga sering menjadi pintu masuk terhadap perilaku seks bebas akibat hilangnya kontrol diri.

Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah tersebut, diperlukan strategi edukasi dan pendekatan yang komprehensif, antara lain:

1. Pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, agar remaja memahami anatomi tubuh, fungsi organ reproduksi, serta risiko dari perilaku seksual yang tidak sehat.
2. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, guna menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman dalam membahas isu seksual.
3. Pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif, seperti organisasi, olahraga, atau kegiatan keagamaan, untuk mengalihkan perhatian dari perilaku berisiko.
4. Akses layanan kesehatan ramah remaja, yang memberikan informasi, konseling, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rahasia dan aman

H. Tinjauan Pustaka (Media Sosial dan Teori)

1. Media sosial

Media sosial menjadi sebuah cara baru bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi digital yang memungkinkan pengguna berkontribusi dalam membuat dan membagikan suatu konten. Hal ini karena media sosial mempunyai karakter unik, seperti konten yang dibuat oleh pengguna, simulasi sosial, interaksi, arsip, informasi, dan jaringan. Tentu ini menjadi pembeda dari media yang lain yang mengundang perhatian dari penggunaannya dengan media yang responsif dan interaktif

2. Teori Uses and Gratification

Elihu Katz, Jay Blumer, dan Michael Gurevitch menjelaskan teori di atas pertama kalinya di tahun 1974 yang didasari adanya penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pengguna mempunyai tanggungjawab media yang mereka pilih dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Diambil dari kutipan (Helen & Rusdi, 2019), Nurudin berpendapat bahwa teori uses and gratification menjelaskan media dari kegunaannya dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu hal yang memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi adalah media.[12] West dan Turner berpendapat bahwa terdapat lima anggapan dari Uses and Gratification untuk mengembangkan teorinya yaitu :

- a. Khalayak aktif, dimana media digunakan berdasarkan tujuan penggunaan
- b. Tindakan cepat yang diberikan khalayak dengan maksud yang sama dengan dihubungkannya sebuah media dengan tercapainya kepuasan kebutuhan penggunaanya
- c. Adanya persaingan diantara media dengan sumber kepuasan yang lain dalam memenuhi kebutuhan
- d. Khalayak memiliki pemahaman akan pemakaian dari sebuah media sehingga dapat menggunakan media dengan tepat
- e. Penilaian dari isi sebuah media yang digunakan hanya dapat dilakukan oleh khalayak.

3. Pemenuhan Kebutuhan Informasi

Sesuai dengan anggapan Rubin (2017) dijelaskan bahwa kebutuhan informasi mengarah kepada kondisi yang terdapat ketidakseimbangan diantara pengetahuan dan tujuan yang ingin diraih. Sesuai dengan asumsi pertama pada teori Uses and Gratification dijelaskan bahwa khalayak memiliki sebuah target dan cara tersendiri sesuai dengan tujuannya atau gratifikasi yang diinginkan dalam menggunakan media. Gratifikasi yang didapatkan dari media modern tentu tidak sama dengan media tradisional. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan dalam pemakaian media sesuai dengan keinginan pengguna dari fitur-fitur yang terdapat pada media modern, Dalam Jurnal Sundar dan Limperos (2013) dilakukan penjelajahan mengenai teori tersebut dimana sebelum itu sudah diciptakan dalam beberapa platform media. Selain itu juga dilakukan penjelajahan terhadap kapasitas daripada kepuasan yang diisyaratkan dalam empat golongan keterjangkauan (Modality, agency, interactivity, dan navigability) sesuai dengan cakupan dari media digital sehingga didapatkan penjelasan yang lebih lengkap untuk dapat ditimbang

4. Metode PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) untuk mempelajari metode dan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam menganalisis media social dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Berdasarkan kutipan dari (Adrillian et al. 2024),

metode ini digunakan karena peneliti dapat menemukan berbagai referensi mengenai metode dan pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti sebelumnya, selanjutnya dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan analisis media social terkait pemenuhan kebutuhan informasinya. Simamora (2024) menyebutkan beberapa tahapan daari penggunaan pendekatan PRISMA adalah identification, scteening, eligibility, dan included.[36] Tahapan yang dilakukan berdasarkan kutipan (Page et al, 2021) dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa literatur yang sesuai dengan cara memakai kata kunci yang sudah dipilih dan dilakukan pencarian artikel dari berbagai database akademik. Pengambilan data dari artikel yang diambil menggunakan aplikasi Publish or Perish. Setelah dilakukan proses identifikasi, tahap berikutnya adalah screening. Hal ini dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap artikel yang sudah dipilih apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Kutipan pada artikel (Polani et al 2019). menjelaskan bahwa pada tahapan ini, judul dan abstrak dari artikel yang sudah dikumpulkan dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah dilakukan tahap screening, tahap selanjutnya adalah eligibility. Hal ini dilakukan dengan membaca isi dari artikel yang sudah diseleksi pada tahap sebelumnya secara keseluruhan Moher et al (2015) menjelaskan bahwa pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian dari

artikel yang dikumpulkan dan kualitasnya. Dengan ini dapat dipastikan bahwa artikel yang terpilih memenuhi standar metodologi yang sudah ditentukan. Tahap terakhir dari pendekatan ini adalah Included. Dalam kutipan (Sabah et al, 2023) dijelaskan bahwa pada tahap ini dilakukan proses analisis berdasarkan artikel yang sudah diseleksi dari tahap eligibility untuk dapat ditarik kesimpulan terkait faktor pada media sosial yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan informasi

I. Platform media yang sering digunakan

Menurut Megan SC, 2024 dalam Junal Young Adults' Use of Different Social Media Platforms for Health Information: Insights From Web-Based Conversations, platform media yang digunakan adalah

1. Facebook (Sosial dan Menggulir)

Banyak anak muda menggambarkan Facebook sebagai penghilang kebosanan ini berarti mereka menghabiskan banyak waktu untuk menelusuri umpan berita mereka, yang sering kali menghasilkan konten terkait kesehatan. Hal ini seringkali berupa artikel berita yang muncul di beranda mereka atau iklan dan unggahan bersponsor, terutama dari perusahaan ritel yang berkaitan dengan kesehatan. Banyak peserta menggambarkan mengabaikan atau tidak memperhatikan iklan di beranda mereka; beberapa orang percaya bahwa mereka secara alami tidak memperhatikan iklan karena mereka terbiasa mengabaikannya. Clickbait dibahas baik secara positif

(menarik perhatian, membuat mereka ingin membaca informasi) maupun negatif (mengurangi kredibilitas sumber informasi dan mengurangi kemungkinan mereka akan mengklik sumber tersebut, karena kemungkinan besar hanya berisi informasi

2. Youtube (Panduan untuk Kehidupan)

YouTube dianggap sebagai sumber yang berguna untuk mempelajari segala hal dan sering menjadi pilihan utama saat mencari informasi atau saran (setelah Google). YouTube adalah sesuatu yang mereka gunakan secara teratur, baik secara langsung sebagai mesin pencari atau lebih pasif melalui video yang direkomendasikan oleh YouTube berdasarkan riwayat pencarian mereka sebelumnya. Banyak yang menyukai format video yang lebih mudah diikuti daripada membaca teks. Demonstrasi dan tutorial dalam format visual juga mempermudah mempelajari keterampilan baru.

3. Instagram (Penampilan Inspiratif)

Instagram terutama digambarkan sebagai sumber inspirasi untuk kesehatan dan kebugaran. Yang sangat menginspirasi adalah mereka yang hidupnya didedikasikan untuk gaya hidup sehat, nutrisi, dan kebugaran, termasuk selebriti, influencer, model, dan pelatih pribadi

Para pengguna Instagram yang mencari informasi kesehatan sebagian besar adalah perempuan, yang mengikuti perempuan lain dan bercita-cita untuk menjadi seperti mereka atau berusaha meniru aspek gaya hidup ideal mereka. Terdapat penekanan yang jelas pada bentuk tubuh perempuan ideal yang menarik, di mana tubuh yang bagus disamakan dengan kesehatan

4. Pinterest (Mengkurasi Ide-Ide Sehat)

Sebagian kecil pengguna menggunakan Pinterest untuk berbagai alasan kesehatan, dan mereka cukup antusias menggunakannya. Pinterest digunakan untuk mencari inspirasi ide dan tips baru, terutama resep dan latihan. Orang-orang juga berbagi konten mereka sendiri untuk terlibat dalam percakapan. Presentasi visual, termasuk foto dan infografis, dianggap menarik dan interaktif. Pinterest terutama digunakan sebagai mesin pencari dan bermanfaat karena kemampuannya untuk membuat papan (board) guna menyimpan informasi dan ide untuk digunakan nanti.

5. Twitter, Tumblr, dan Snapchat (Bukan Tentang Kesehatan)

Platform-platform ini digunakan oleh orang dewasa muda tetapi jarang untuk mencari atau mendiskusikan informasi kesehatan. Beberapa peserta menyebutkan mengikuti tokoh atau perusahaan terkait kesehatan seperti Taste atau The Food Network di Snapchat. Selain itu, Snapchat digunakan untuk mengobrol dengan teman; Twitter digunakan untuk mengikuti berita, selebriti, dan olahraga; dan Tumblr, untuk meme

Dari platform diatas yang paling di gunakan pada remaja adalah bahwa Snapchat digunakan untuk humor, Instagram digunakan untuk presentasi diri, dan YouTube digunakan untuk menghabiskan waktu, sedangkan Survei terhadap mahasiswa dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa Facebook dan Snapchat terhubung dengan teman-teman di kehidupan nyata, sedangkan Twitter dan Instagram digunakan untuk terhubung dengan orang asing Remaja etnis Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat melaporkan melihat gambar makanan di Snapchat dan Instagram, sedangkan Facebook lebih banyak digunakan untuk berbagi informasi tentang kesehatan dan penyakit Dalam 1 penelitian, 12 mahasiswi mencatat penggunaan media sosial mereka dan menggambarkan penggunaan Facebook untuk dukungan sosial dan pengumpulan informasi, sedangkan Pinterest dan Instagram digunakan untuk resep, program olahraga, dan inspirasi

J. Simpulan

Kesehatan Wanita sub remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Pada masa remaja akan mengalami perubahan fisik, psikologis, kognitif sosial yang akan membentuk pola pikir dan perubahan pada sikap dan perilaku sehingga memperoleh cara berpikir orang dewasa, dan mencapai kemandirian yang lebih besar dari keluarganya, mengembangkan cara yang lebih dewasa dalam berhubungan dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, dan mulai membangun identitas—rasa percaya diri yang kuat tentang siapa dirinya dalam hal nilai dan tujuan hidup seksual, kejuruan, moral, etnis, agama, dan pengguna media sosial, penggunaan media sosial yang pada remaja diantaranya yaitu face book, youtube, instgram dll dalam mencari informasi kebutuhan kesehatan dan banyak lagi

K. Referensi

- Almeida, R. A. S., & de Oliveira, S. M. J. V. (2021). Nursing care for pregnant adolescents: An integrative review. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 74(Suppl 4), e20200671. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0671>
- Ariyani, M., & Kamilia, F. (2015). Penyesuaian diri pada remaja yang menjadi ibu. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(1), 18-22.
- Ayuni, I. D., Islami, D., Jannah, M., Putri, A., & Nurhasanah. (2022). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri

Terhadap Bahaya Kehamilan Pada Usia Remaja. *Indonesia Journal of Midwifery and Health Sciences*, 2(1), 47-52.

Berk, L. E. (2022). *Development through the lifespan* (7th ed). Sage Publication

Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

Husna, F., Akbar, M. I. A., & Amalia, R. B. (2019). Komplikasi kehamilan dan persalinan pada kehamilan remaja. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 3(2), 138-147.

Kusumawati, I. (2022). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendidikan Seksual Komprehensif*. Yogyakarta: Deepublish.

Muthmainnah,dkk, 2022, What are Adolescent Health Information Needs in the Pandemic Era, *Journal of Positive School Psycholog*, <http://journalppw.com/>, Vol. 6, No. 8, 8518 – 8524

Natosba, J., Ramadhan, G. E., Keumalahayati, & Probowati, R. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Deepublish.

Prawirohardjo, S. (2019). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Ramadani, M., Nursal, D. G. A., & Ramli, L. (2015). Peran tenaga kesehatan dan keluarga dalam kehamilan usia remaja. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 10(2), 87-92. <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v10i2.885>

- Saryono & Wulandari. (2018). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Surbakti.GNP, Besse Hartati, Susaningsih, C,2025, *Analisis Faktor Pada Media Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Menggunakan Pendekatan Prisma*, Journal of Information System Management (JOISM), e-ISSN: 2715-3088, Vol. 7, No. 1 (2025
- UNICEF. (2022). *Child marriage around the world*. Diakses dari <https://www.unicef.org/>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Adolescent pregnancy*. Diakses dari <https://www.who.int/>
- Yastirin, P. A., Sahara, R., & Selmawati. (2024). Dampak kesehatan ibu pada kehamilan remaja. *Jurnal Profesi Bidan Indonesia*, 4(2), 18-33.
- Yudaninggar,Ks, Subektiningsih,2023, *Sosialisasi Pendampingan dan Penggunaan Internet pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)*. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat,DOI; 10.35311/jmpm.v4i1.147,ISSN 2722-4902. e-ISSN 2745-3588,

CHAPTER 3

PERAN PERAWAT DALAM ASUHAN KEPERAWATAN HOLISTIK

Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An

A. Pendahuluan

Asuhan keperawatan holistik merupakan pendekatan yang digunakan dalam pelayanan keperawatan yang memandang seorang individu sebagai kesatuan yang terdiri dari dimensi biologis, psikologis, sosial dan spiritual (Ambushe et al., 2023). Pelayanan keperawatan berakar dari seni dan sains mengenai pemahaman mendalam tentang eksistensi manusia, sehingga perawat memandang pasien bukan sebagai kumpulan gejala klinis, melainkan sebagai individu yang utuh. Pendekatan ini mengarahkan perawat untuk tidak hanya berfokus pada kondisi penyakit secara fisik, tetapi juga memahami kehidupan pasien dalam konteks yang menyeluruh, termasuk keyakinan, nilai, budaya serta lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan seseorang (Gripshi, 2021).

Seiring pelayanan kesehatan yang makin modern dan berfokus pada *patient centered care*, maka peran

perawat menjadi sangat strategis karena perawat terus kebersamai pasien dan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki interaksi paling sering dengan pasien, sehingga hal ini memudahkan perawat untuk mengintegrasikan asuhan keperawatan holistik dalam praktik keperawatan sehari-hari (Kwame & Petrucka, 2021). Hal ini sejalan dengan teori keperawatan *Human caring* yang dikemukakan oleh *Jean Watson*, yang memandang keperawatan sebagai sebuah komitmen moral untuk dapat melindungi, meningkatkan dan mengoptimalkan martabat manusia, dimana aspek psiko-spiritual dianggap sama pentingnya dengan intervensi yang akan mempercepat proses penyembuhan (Devi et al., 2022).

Asuhan keperawatan holistik dapat dijalankan ketika perawat berperan sebagai pemberi asuhan (care provider), edukator (educator), advokat, koordinator dan kolaborator. Pelaksanaan peran tersebut perlu disertai dengan kompetensi klinis, kemampuan dalam berkomunikasi terapeutik, sensitif terhadap budaya yang dimiliki, serta etika dan moral yang sesuai dan bermakna bagi pasien. Dengan demikian, memahami peran perawat dalam pendekatan asuhan keperawatan holistik akan menjadi landasan dalam mengembangkan kualitas pelayanan keperawatan secara komprehensif, humanistik serta berorientasi bagi terciptanya

kesejahteraan individu yang menyeluruh (Eriksson et al., 2018).

B. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Holistik

1. Peran perawat sebagai pemberi asuhan

Pelayanan asuhan keperawatan yang holistik diberikan oleh perawat dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan. Pelaksanaannya merupakan inti praktik profesional keperawatan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah dalam proses keperawatan yang sistematis, meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perawat tidak hanya berfokus pada keluhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, spiritual dan budaya yang dimiliki pasien. Dengan demikian, diharapkan asuhan keperawatan yang holistik dapat dilakukan dan memenuhi kebutuhan pasien. Melalui pendekatan yang holistik, asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi secara menyeluruh pada pemulihan kesehatan pasien (Renghea et al., 2022).

Upaya perawat untuk dapat memberi asuhan keperawatan yang holistik maka perawat perlu memiliki kemampuan analisis klinis dan hubungan

yang terapeutik. Pengkajian bukan hanya terbatas pada tanda dan gejala penyakit, namun perawat juga memperhatikan respon emosional pasien, dukungan yang diberikan keluarga, kondisi lingkungannya, serta nilai dan keyakinan yang dianut oleh pasien. Berbagai informasi tersebut menjadi landasan bagi perawat dalam menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga intervensi keperawatan yang diberikan dapat berjalan efektif secara klinis dan relevan dengan kebutuhan pasien sebagai individu yang unik (Cabete et al., 2019). Dengan demikian, perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, dan pendekatan yang humanistik dalam praktik asuhan keperawatan.

Pelaksanaan peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan yang holistik juga memerlukan kemampuan berkolaborasi interprofesional yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Perawat diharapkan mampu menjalin komunikasi dan kerja tim dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan kesinambungan pelayanan dan meminimalkan fragmentasi dalam asuhan terhadap pasien. Oleh karenanya, kompetensi yang profesional, empati serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan

menjadi fondasi untuk menjalankan peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan holistik yang berkualitas (Alrashid et al., 2025).

2. Peran perawat sebagai pendidik

Peran perawat sebagai pendidik menjadi dasar dalam melaksanakan praktik keperawatan yang profesional dan berorientasi untuk memandirikan dan meningkatkan kemampuan pasien agar dapat mengelola kesehatannya secara mandiri. Perawat memberikan edukasi kesehatan sebagai bagian dari intervensi terapeutik non-farmakologis yang akan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi yang dijalankan, menurunkan jumlah kekambuhan serta memperbaiki keadaan klinis pasien. Pendidikan kesehatan merupakan strategi terbaik untuk mempromosikan kesehatan dan membantu pasien dalam mengembangkan kemampuan literasi kesehatan, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta menjalankan perilaku hidup sehat yang berkelanjutan (Zolbin et al., 2022). Dengan demikian, edukasi kesehatan yang diberikan perawat bukan hanya pelengkap intervensi klinis, namun menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan yang holistik dan ilmiah.

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai pendidik, perawat juga dituntut memiliki kompetensi

pedagogik, yaitu perawat dapat mengidentifikasi kemampuan dan menilai kebutuhan belajar pasiennya, merancang materi edukasi, memilih metode pembelajaran yang sesuai serta melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil edukasi yang dijalankan. Pendidikan terhadap pasien merupakan suatu proses yang sistematis dan perlu disesuaikan dengan karakteristik individu, termasuk tingkat literasi pasien, kesiapannya untuk memulai proses belajar, latar belakang budaya, serta kondisi emosionalnya (Bastable, 2019). Pendidikan yang spesifik dan sesuai kebutuhan individu menjadi hal yang penting agar seluruh pesan kesehatan dapat dipahami secara optimal dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran perawat sebagai pendidikan juga memiliki dimensi etik dan profesional yang menekankan tanggung jawab advokasi terhadap pemenuhan hak pasien dalam memperoleh informasi kesehatan yang memadai dan jelas. Edukasi pasien merupakan bagian dari pelaksanaan standar praktik keperawatan profesional yang penting dijalankan secara konsisten dalam berbagai tatanan pelayanan asuhan keperawatan (Baker et al., 2021). Dengan demikian, perawat bukan saja memberikan informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran

yang akan memandirikan pasien dan keluarganya agar terlibat aktif dalam perawatan, membuat keputusan yang tepat, serta mampu memelihara kesehatan.

3. Peran perawat sebagai advokat pasien

Peran perawat sebagai advokat pasien merupakan dimensi yang esensial dalam melaksanakan praktik keperawatan profesional untuk perlindungan hak, keselamatan, dan martabat manusia dalam pelayanan kesehatan, terutama ketika pasien berada dalam situasi dan kondisi yang rentan baik secara fisik maupun psikologis. Perawat diminta untuk mampu melaksanakan standar praktik keperawatan dan melindungi hak-hak pasiennya dalam memperoleh informasi, mengambil keputusan yang tepat serta menerima pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas (Tønnessen et al., 2020). Dengan demikian, advokasi bukan hanya sikap pilihan, melainkan menjadi kewajiban yang melekat pada profesi perawat secara profesional.

Pelaksanaan asuhan keperawatan yang holistik memerlukan komitmen perawat untuk berperan sebagai advokat, yaitu perawat berperan memastikan pasien memahami kondisi kesehatan yang dihadapinya, pilihan terapi apa saja yang tersedia dan cara memperolehnya, serta konsekuensi setiap

keputusan klinis pasien, baik yang sesuai dengan program terapi maupun yang bertentangan dengan program. Perawat juga memiliki kewajiban untuk berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko, kesalahan medis atau praktik yang tidak etis, lalu menyampaikan sesuai jalur komando secara profesional kepada tim. *International Council of Nurses* mengungkapkan bahwa advokasi merupakan bagian dari tanggung jawab perawat dalam menjunjung tinggi hal otonomi pasien, keadilan, dan keselamatan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan (International Council of Nurses, 2021). Oleh karena itu, perawat perlu memiliki kemampuan komunikasi yang asertif, penalaran etik yang tajam, serta pemahaman mengenai hukum kesehatan yang berlaku agar efektif dalam menjalankan perannya sebagai advokat pasien.

Peran perawat sebagai advokat pasien juga memengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan, penjaminan akses pelayanan yang setara, serta pengurangan ketimpangan kesehatan di masyarakat. Sistem kesehatan penting untuk diperkuat dalam memprioritaskan keselamatan pasien, keadilan pelayanan serta perlindungan bagi kelompok rentan/berisiko (Hemingway & Bosanquet, 2018). Dengan demikian, peran perawat sebagai advokat

bukan hanya berpengaruh pada kesejahteraan pasien, tetapi juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan sistem kesehatan secara luas.

4. Peran perawat sebagai koordinator dan kolaborator

Peran perawat sebagai koordinator dan kolaborator merupakan salah satu peran perawat dalam menjalankan fungsi strategis untuk kesinambungan dan integrasi *patient-centered care*. Perawat memiliki tanggung jawab sebagai koordinator untuk mengatur berbagai komponen di pelayanan, mulai dari mengkaji kebutuhan pasien, merencanakan asuhan keperawatan, serta memantau respon pasien terhadap program terapi yang dijalankan pada pasien. Pada sistem pelayanan kesehatan yang modern, peran sebagai koordinator merupakan hal yang krusial karena melibatkan berbagai profesi dan unit layanan yang saling terhubung. *World Health Organization* menekankan bahwa elemen penting dalam meningkatkan mutu layanan, pemenuhan standar keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan memerlukan koordinasi antar berbagai profesi (World Health Organization, 2018). Perawat berperan penting sebagai penghubung melalui fungsinya untuk

memastikan rencana perawatan dapat bersinergi dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Peran perawat sebagai kolaborator dilaksanakan melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, apoteker, analis, fisioterapis dan profesi kesehatan lainnya dalam praktik interprofesional. Kolaborasi ini memerlukan kompetensi dalam komunikasi efektif, saling menghargai peran masing-masing profesi serta pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. kolaborasi interprofesional merupakan suatu standar praktik keperawatan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan pengendalian mutu pelayanan (Dilles et al., 2021).

Pada sistem pelayanan kesehatan, peran koordinasi dan kolaborasi yang dilaksanakan oleh perawat menjadi penting dalam kepemimpinan klinis. Perawat sering menjadi sumber komunikasi informasi klinis karena perawat merupakan profesi tenaga kesehatan yang paling sering dan lama bertemu dengan pasien dan keluarganya, sehingga perawat berperan penting dalam menyampaikan perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu kepada tim kesehatan lainnya. *International Council of Nurses* menekankan bahwa kompetensi inti

pelayanan keperawatan profesional dapat dicapai melalui kolaborasi yang efektif sehingga berkontribusi pada keselamatan pasien, efisiensi layanan dan perawatan yang kontinyu (International Council of Nurses, 2021). Oleh karenanya, penguatan peran perawat sebagai kolaborator dan koordinator menjadi aspek yang penting dalam mengembangkan profesionalitas profesi perawat agar mampu menjalankan fungsinya dengan optimal.

C. Tantangan dalam Penerapan Asuhan Keperawatan Holistik

1. Integrasi riset dalam praktik keperawatan

Integrasi riset dalam praktik keperawatan merupakan fondasi utama dalam praktik yang berbasis bukti (evidence-based practice). Integrasi ini akan memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan kepada pasien didasarkan pada temuan ilmiah terbaik yang tersedia. Pendekatan ini mendukung perawat memberikan asuhan holistik yang aman, efektif, dan terstandar. Penggunaan bukti ilmiah dalam pelayanan kesehatan merupakan strategi yang penting guna meningkatkan kualitas layanan serta efisiensi dalam sistem kesehatan secara global (Theobald et al., 2018). Oleh karenanya, perawat diharapkan memiliki kompetensi yang esensial dalam mengakses, menilai, dan menerapkan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan.

Selain meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, integrasi riset juga berperan dalam memperkuat kapasitas intelektual dan keprofesionalan perawat. proses telaah literatur ilmiah, memahami metodologi penelitian, serta mengevaluasi validitas temuan akan mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang rasional. Praktik berbasis bukti merupakan integrasi terbaik antara bukti

penelitian terbaik, keahlian klinis, nilai keyakinan dan preferensi pasien dalam menentukan tindakan keperawatan yang paling tepat (Theobald et al., 2018). Dengan demikian, riset bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, namun juga sebagai alat refleksi profesional untuk meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan dan holistik.

Integrasi riset bukan hanya bermanfaat dalam pelaksanaan praktik keperawatan, namun juga mendorong terbentuknya budaya ilmiah dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya berperan sebagai pengguna hasil penelitian, tetapi juga berperan sebagai profesi yang terlibat dalam penelitian klinis dan evaluasi praktik pelayanan kesehatan. Partisipasi perawat dalam penelitian merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk meningkatkan standar praktik, kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Yang et al., 2025). Oleh karenanya, dukungan institusi, akses yang mudah terhadap sumber ilmiah, serta penguatan literasi riset menjadi faktor yang penting dalam memastikan integrasi penelitian dan praktik keperawatan holistik secara berkesinambungan.

2. Penggunaan teknologi kesehatan

Penggunaan teknologi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan holistik merupakan kemajuan yang mendukung pelayanan yang lebih komprehensif, terintegrasi dan berpusat pada pasien. Teknologi seperti penggunaan rekam medis elektronik, telehealth, sistem

pemantauan pasien, dan aplikasi kesehatan digital memungkinkan perawat mengakses data klinis sesuai waktu terkini serta memantau kondisi pasien secara lebih mudah dan berkelanjutan. Transformasi digital di sektor pelayanan kesehatan berperan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kemudahan akses, serta memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh (Emran et al., 2025). Dengan dukungan teknologi yang tepat perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien secara lebih akurat dan merancang intervensi dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual secara terintegrasi.

Dalam praktik pelayanan klinis, teknologi juga dapat memperkuat proses pengambilan keputusan keperawatan yang berbasis data dan bukti. Sistem pendukung yang tersedia akan membantu perawat menilai risiko, menentukan prioritas intervensi serta mencegah kesalahan dalam tindakan. Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan dapat meningkatkan keselamatan pasien, koordinasi pelayanan, dan efisiensi tenaga kerja di bidang kesehatan (Sittig et al., 2020). Dengan demikian teknologi tidak akan menggantikan peran perawat, melainkan akan memudahkan dan memperluas kapasitas profesionalitas perawat dalam memberikan asuhan yang lebih tepat dan responsif dalam perubahan kondisi pasien.

Integrasi teknologi dalam asuhan keperawatan holistik juga meningkatkan pemberdayaan pasien melalui

peningkatan literasi kesehatan dan partisipasi aktif dalam perawatan. Aplikasi yang digunakan untuk pemantauan mandiri, platform edukasi digital, dan layanan konsultasi jarak jauh memungkinkan pasien terlibat dalam pengelolaan kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi merupakan bagian dari kompetensi perawat modern yang harus digunakan secara etis mengikuti kaidah yang berlaku, aman dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Emran et al., 2025). Oleh karenanya, penguasaan teknologi kesehatan, literasi digital, serta pemahaman etika informasi menjadi prasyarat ketika perawat akan menggunakannya dalam memberikan asuhan holistik yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Dengan demikian, asuhan keperawatan holistik dapat diwujudkan secara efektif.

3. Inovasi pelayanan keperawatan holistik

Inovasi pelayanan dalam asuhan keperawatan holistik merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan metode, model intervensi, dan pendekatan praktik yang responsif terhadap kebutuhan multidimensional pasien. Inovasi tersebut dapat berupa penerapan model perawatan terintegrasi, penggunaan teknologi digital, pengembangan intervensi yang berbasis komunitas, serta pendekatan *patient-centered care* yang menekankan partisipasi aktif pasien dan keluarganya. Inovasi dalam pelayanan kesehatan berperan penting dalam memperkuat sistem kesehatan, mempermudah akses, dan

menghasilkan luaran kesehatan yang lebih optimal (Flessa & Huebner, 2021). Inovasi praktik keperawatan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk menjawab tantangan kompleksitas kebutuhan pasien modern (International Council of Nurses, 2021). Dengan demikian, kreativitas klinis, kemampuan adaptasi serta dukungan organisasi menjadi penentu dalam mendorong perawat mengembangkan inovasi pelayanan yang berlandaskan prinsip ilmiah, etik dan holistik. Adapun beberapa inovasi pelayanan holistik meliputi:

a. *Telehealth*

Telehealth merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang signifikan berperan dalam mendukung asuhan keperawatan holistik karena memberikan akses layanan secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas interaksi terapeutik. Melalui telehealth, perawat dapat memantau kondisi pasien, memberikan edukasi kesehatan, melakukan konseling serta mengevaluasi program terapi yang diberikan secara berkelanjutan, sehingga aspek fisik, psikologis, sosial dan edukasional pasien dapat dipenuhi. Melalui teknologi kesehatan telehealth, maka akses pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, memberikan kontinuitas layanan serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan terutama pada populasi dengan keterbatasan geografis (Sharma et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa telehealth merupakan bagian penting dari transformasi

pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan berkesinambungan.

Telehealth mulai berkembang pada tahun 2013 dan 52% rumah sakit mulai menggunakannya. Meskipun awalnya telehealth dikembangkan dengan tujuan menjangkau area pedesaan dan daerah yang kurang terlayani, namun hasil-hasil penelitian terbaru menemukan bahwa telehealth mulai digunakan di wilayah perkotaan dan menjangkau berbagai layanan spesialisik. Seperti pada umumnya penggunaan teknologi, telehealth memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari telehealth diantaranya pasien memiliki akses yang lebih mudah, menghemat biaya, efisiensi meningkat, dan pasien lebih terlibat dengan hasil yang lebih baik di dalam program. Adapun kekurangannya meliputi keterbatasan dalam pemeriksaan fisik, potensi masalah teknis digital, pelanggaran keamanan, serta hambatan terkait regulasi (Balestra, 2018).

b. Digital nursing care

Digital *nursing care* merupakan suatu inovasi dalam pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemberian asuhan keperawatan secara komprehensif, terintegrasi dan berpusat kepada pasien. Pendekatan ini meliputi penggunaan rekam medis elektronik, sistem pemantauan pasien yang modern, aplikasi kesehatan serta platform komunikasi digital yang memungkinkan

perawat memantau kondisi pasien secara akurat dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta pertukaran informasi kesehatan secara cepat dan akurat. Integrasi teknologi digital dalam praktik keperawatan akan memperluas kapasitas perawat dalam memberikan asuhan yang holistik sekaligus beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan sistem kesehatan masa kini (Swain & Sahu, 2025).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat beberapa jenis digital *nursing care* yang telah dilakukan diantaranya sistem informasi rumah sakit, catatan kesehatan elektronik, sistem pendukung keputusan secara komputerisasi, telecare, dukungan komunikasi umum, sistem untuk perencanaan dan pertukaran data, aplikasi khusus, aplikasi pertemuan khusus untuk kelompok sasaran, serta teknologi robot. selain itu juga ditemukan penggunaan sensor untuk monitoring pasien, alat bantu dengan teknologi digital, serta *virtual reality* (Huter et al., 2020).

c. Model pelayanan integratif

Model pelayanan integratif dalam asuhan keperawatan holistik merupakan pendekatan yang digunakan dengan menggabungkan berbagai aspek intervensi kesehatan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh. Model ini berfokus pada koordinasi antar profesi, kesinambungan perawatan, serta mencakup layanan promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang terintegrasi merupakan strategi yang penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesinambungan dalam asuhan keperawatan. Melalui pendekatan integratif, perawat dapat mengkaji dan memenuhi kebutuhan pada dimensi fisik, psikologis, sosial dan spiritual pasien sehingga intervensi keperawatan yang diberikan lebih komprehensif (Feng et al., 2025).

Model integratif dalam pelayanan keperawatan juga memperkuat peran perawat sebagai penghubung utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran mengkoordinasikan rencana perawatan, memfasilitasi komunikasi antar profesi, serta memastikan bahwa kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara konsisten dalam berbagai tingkat pelayanan. Praktik keperawatan yang profesional menuntut kolaborasi yang efektif antar profesi kesehatan dan menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk menjamin keselamatan pasien. Oleh karenanya, penerapan model pelayanan integratif merupakan inovasi dalam pelayanan kesehatan, dan bermanfaat untuk meningkatkan hasil klinis serta memperkuat peran strategis perawat dalam sistem kesehatan yang kompleks dan dinamis (Feng et al., 2025).

D. Hambatan dalam Pelayanan Kesehatan yang holistik

1. Beban kerja

Beban kerja merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan pelayanan kesehatan yang holistik. Tingginya jumlah pasien, kompleksitas kasus klinis serta tuntutan administratif sering menyebabkan tenaga kesehatan, khususnya perawat lebih berfokus pada penyelesaian tugas fisik dan prosedural daripada pemenuhan kebutuhan pasien secara menyeluruh. Kondisi ini yang tidak ditangani akan mengurangi kesempatan perawat untuk melakukan asuhan keperawatan holistik seperti pengkajian yang komprehensif, komunikasi terapeutik, serta intervensi psikososial dan spiritual yang sebenarnya merupakan komponen penting dalam pendekatan holistik pada pasien. Maka dampaknya pelayanan kesehatan cenderung menjadi fragmentaris dan berorientasi pada penyakit, bukan menyelesaikan masalah sebagai manusia secara utuh (Guevara et al., 2022).

Selain berdampak pada kualitas asuhan keperawatan, beban kerja yang berlebihan juga dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga kesehatan itu sendiri, seperti peningkatan kelelahan, stres kerja, dan risiko *burnout*. Keadaan tersebut berpotensi menurunkan konsentrasi kerja, empati serta ketelitian dalam pekerjaan. Hal ini dapat memengaruhi pelaksanaan standar asuhan dan keselamatan pasien serta mutu pelayanan. Oleh karenanya, pengelolaan beban kerja yang proporsional

dan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif menjadi hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang holistik, manusiawi dan berkualitas (Lu et al., 2023).

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu hambatan utama dalam pelayanan keperawatan yang holistik karena pendekatan ini membutuhkan tenaga, waktu, fasilitas, serta dukungan sistem yang memadai. Maka saat jumlah tenaga keperawatan tidak sebanding dengan jumlah pasien atau fasilitas kesehatan yang lengkap, maka fokus pelayanan seringkali menjadi bergeser pada penanganan masalah medis saja, sedangkan aspek psikologis, sosial, spiritual dan edukatif pasien menjadi tidak diterapkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan pelayanan keperawatan menjadi parsial dan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip holistik yang menekankan pemenuhan kebutuhan pasien secara menyeluruh dan komprehensif (Momeni et al., 2022).

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya juga berdampak pada kualitas interaksi terapeutik antara perawat dengan pasien. Keterbatasan alat, akses teknologi, ruang perawatan, maupun dukungan sistem rujukan dapat menghambat koordinasi pelayanan dan kesinambungan asuhan keperawatan yang berkualitas. situasi tersebut bukan hanya memengaruhi efektivitas

intervensi keperawatan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepuasan pasien dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas sumber daya, baik melalui peningkatan jumlah tenaga kerja, pengembangan kompetensi, maupun penyediaan fasilitas yang memadai, menjadi suatu langkah yang strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar holistik dan berkualitas (Anwar & Abdullah, 2021).

3. Faktor organisasi

Faktor organisasi merupakan salah satu hambatan dalam implementasi pelayanan kesehatan yang holistik karena struktur, kebijakan dan budaya kerja suatu institusi sangat memengaruhi pola praktik tenaga kesehatan. Sistem organisasi yang terlalu berorientasi pada target administratif dan indikator kuantitatif sering kali membatasi kesempatan tenaga kesehatan untuk memberikan perhatian menyeluruh terhadap kebutuhan pasien. Kurangnya dukungan kebijakan internal, standar operasional yang tidak terintegrasi, serta lemahnya koordinasi antar unit pelayanan dapat menyebabkan pelayanan menjadi terfragmentasi, sehingga pendekatan holistik yang menekankan kesinambungan dan kolaborasi sulit terwujud secara optimal (Kern et al., 2024).

Budaya organisasi yang tidak mendukung implementasi komunikasi yang terbuka, kerja tim interprofesional, dan pengembangan profesional berkelanjutan juga dapat menghambat penerapan asuhan

keperawatan yang holistik. Lingkungan kerja yang minim dukungan kepemimpinan cenderung menurunkan motivasi tenaga kesehatan untuk berinovasi dan berinisiatif dalam memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Oleh karenanya, transformasi organisasi melalui kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang berorientasi pada pasien, serta sistem manajemen yang mendukung kolaborasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang memungkinkan penerapan praktik kesehatan holistik yang terlaksana secara efektif (Khatri et al., 2023).

E. Simpulan

Asuhan keperawatan holistik merupakan pendekatan yang digunakan dalam pelayanan keperawatan yang memandang seorang individu sebagai kesatuan yang terdiri dari dimensi biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Peran perawat yang mendukungnya meliputi peran sebagai pemberi asuhan, pendidik, advokat pasien, koordinator dan kolaborator. Dalam penerapannya, perawat memiliki tantangan terkait integrasi riset dalam praktik, penggunaan teknologi kesehatan, dan inovasi pelayanan keperawatan holistik. Hambatan yang dapat ditemui terkait dengan beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan faktor organisasi. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kompetensi perawat dalam asuhan keperawatan yang holistik dan kolaborasi interprofesional tenaga kesehatan; 2) Mengadvokasi institusi

penyedia layanan kesehatan dalam penyediaan tenaga kesehatan secara proporsional dan penerapan asuhan keperawatan yang holistik dan berkualitas.

F. Referensi

- Alrashid, A. S., Ibrahimalsaleh, F. A., Aljohany, S. S., Alkhaibari, H. A. S., Alhejaili, N. N., Alhusayni, R. S., Aljohani, H. S., Al Johani, W. M. Al, Aljohani, R. M., & Aljohani, S. M. (2025). A qualitative theoretical framework for collaborative practice among midwives, nursing technicians, nursing specialists, emergency nurse specialists, and general nursing technicians in holistic patient care. *Vascular and Endovascular Review*, 8(18s), 137–147.
- Ambushe, S. A., Awoke, N., Demissie, B. W., & Tekalign, T. (2023). *Holistic nursing care practice and associated factors among nurses in public hospitals of Wolaita zone, South Ethiopia*. 22(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12912-023-01517-0>
- Anwar, G., & Abdullah, N. N. (2021). The impact of Human resource management practice on Organizational performance. *International Journal of Engineering, Business and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22161/ijebm.5.1.4>
- Baker, C., Cary, A. H., & Bento, C. (2021). Global standards for

professional nursing education: The time is now. *Journal of Professional Nursing*, 37(1), 86–92.
<https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.10.001>

Balestra, M. (2018). Telehealth and Legal Implications for Nurse Practitioners. *The Journal for Nurse Practitioners*, 14(1), 33–39.
<https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2017.10.003>

Bastable, S. (2019). *Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice* (5 th). Jones & Bartlett Learning.

Cabete, D. dos S. G., da Fonte, C. S., de Matos, M. M. S., Patrica, H. M., Silva, A. R. R., & de Abranches Silva, V. F. V. (2019). Emotional support to the family of the critically ill patient: nursing interventions. *Revista de Enfermagem Referência*, 4(20), 129–137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.12707/RIV18062>

Devi, B., Pradhan, S., Giri, D., & Lepcha, N. (2022). *Watson 's theory of caring in nursing education: challenges to integrate into nursing practice*. 6(4), 1464–1471.

Dilles, T., Heczkova, J., Tziaferi, S., Helgesen, A. K., Grøndahl, V. A., Rompaey, B. Van, Sino, C. G., & Jordan, S. (2021). Nurses and pharmaceutical care: Interprofessional, evidence-based working to improve

patient care and outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5973), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph18115973>

Emran, H. A., Salem, M. A., & El-hony, F. M. (2025). The impact of digital transformation strategies on the quality of health services - field study. *Journal of Educational Analytics*, 4(4), 1079–1090.

Eriksson, I., Lindblad, M., Möller, U., & Gillsjö, C. (2018). Holistic health care: Patients ' experiences of health care provided by an advanced practice nurse. *International Journal of Nursing Practice*, 24(e12603), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ijn.12603>

Feng, T., Zhao, P., Wang, J., Du, X., Ai, M., Yang, J., & Li, J. (2025). Therapeutics and Clinical Risk Management Improving Patient Outcomes in mTBI: The Role of Integrated Nursing Interventions in the Improving Patient Outcomes in mTBI: The Role of Integrated Nursing Interventions in the Emergency Department. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 69–80.
<https://doi.org/10.2147/TCRM.S500328>

Flessa, S., & Huebner, C. (2021). Innovations in health care — A conceptual framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10026.

<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph181910026>

- Gripshi, S. (2021). The importance of holistic nursing care. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria*, 5(2), 544–549.
- Guevara, J. A. C., Díez, N. P., Vrotsou, K., Machón, M., Orruño, E., Ecenarro, M. J. O., Sampedro, M. M., & Cobos, J. R. D. L. (2022). Factors associated with the workload of health professionals in hospital at home: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 22, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08100-4>
- Hemingway, A., & Bosanquet, J. (2018). Role of nurses in tackling health inequalities. *Journal of Community Nursing*, 32(6), 62–64.
- Huter, K., Krick, T., Domhoff, D., Seibert, K., Wolf-ostermann, K., & Rothgang, H. (2020). Effectiveness of digital technologies to support nursing care: results of a scoping review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 1905–1926. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S286193>
- International Council of Nurses. (2021). *International council of nurses: The ICN code of ethics for nurses*. ICN.
- Kern, L. M., Bynum, J. P. W., & Pincus, H. A. (2024). Care Fragmentation, Care Continuity, and Care Coordination—How They Differ and Why It Matters. *JAMA Intern Med.*, 184(3), 236–

237.

<https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.7628.Care>

Khatri, R., Endalamaw, A., Erku, D., Wolka, E., Nigatu, F., Zewdie, A., & Assefa, Y. (2023). Continuity and care coordination of primary health care: a scoping review. *BMC Health Services Research*, 23, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09718-8>

Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward. *BMC Nursing*, 20(158), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12912-021-00684-2>

Lu, Y., Zhang, M. M., Yang, M. M., & Wang, Y. (2023). *Sustainable human resource management practices, employee resilience, and employee outcomes: Toward common good values*. 62, 331–353. <https://doi.org/10.1002/hrm.22153>

Momeni, G., Hashemi, M. S., & Hemati, Z. (2022). Barriers to providing spiritual care from a nurses ' perspective: A Content analysis study. *Iran J Nurs Midwifery Res*, 27, 575–580. <https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr>

Renghea, A., Cuevas-budhart, M. A., Yébenes-Revuelto, H., Gómez del Pulgar, M., & Iglesias-López, M.

- T. (2022). "Comprehensive Care" concept in nursing: Systematic review. *Invest. Educ. Enferm.*, 40(3), e05. <https://doi.org/https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n3e05>
- Sharma, A., Pruthi, M., & Sageena, G. (2022). Adoption of telehealth technologies: An approach to improving healthcare system. *Translational Medicine Communications*, 7(20), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41231-022-00125-5>
- Sittig, D. F., Wright, A., Magrabi, E. C. and F., Ratwani, R., Bates, D. W., & Singh, H. (2020). Current challenges in health information technology – related patient safety. *Health Informatics Journal*, 26(1), 181–189. <https://doi.org/10.1177/1460458218814893>
- Swain, M., & Sahu, S. (2025). Reimagining integrative nursing through digital health: A call for holistic innovation. *J Integr Nurs*, 7, 249–253. <https://doi.org/10.4103/jin.jin>
- Theobald, S., Brandes, N., Gyapong, M., El-saharty, S., Proctor, E., Diaz, T., Wanji, S., Elloker, S., Raven, J., Elsey, H., Bharal, S., Pelletier, D., & Peters, D. H. (2018). Health policy implementation research: New imperatives and opportunities in global health. *The Lancet*, 392, 2214–2228. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32205-0](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32205-0)

- Tønnessen, S., Scott, A., & Nortvedt, P. (2020). Safe and competent nursing care: An argument for a minimum standard ? *Nursing Ethics*, 27(6), 1396–1407.
<https://doi.org/10.1177/0969733020919137>
- World Health Organization. (2018). *Continuity and coordination of care*. World Health Organization.
- Yang, H., Chen, Y., & Peng, X. (2025). An ideal portrait of the professional competence of clinical research nurses: A qualitative study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 12(March), 100682.
<https://doi.org/10.1016/j.apjon.2025.100682>
- Zolbin, M. G., Huvila, I., & Nikou, S. N. (2022). Health literacy, health literacy interventions and decision-making: a systematic literature review. *Journal of Documentation*, 78(7), 405–428.
<https://doi.org/10.1108/JD-01-2022-0004>

G. Glosarium

Patient-centered care = asuhan yang berpusat kepada pasien

CHAPTER 4

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER

Dr. Peny Ariani, M.Keb., Bd.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat dengan cara yang dapat diakses, komprehensif, dan berkesinambungan (WHO, 2018b). Di Indonesia, PHC diwujudkan dalam bentuk Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya yang menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional (10.180 Puskesmas pada 2023) sebagai kontak pertama masyarakat dengan layanan kesehatan. Meski begitu, data menunjukkan tantangan nyata dalam pelayanan primer (Kemenkes, 2024e). Berdasarkan profil tenaga kesehatan country profile, hanya sekitar 56,4% Puskesmas yang memiliki jumlah tenaga kesehatan sesuai standar 9 jenis profesional kesehatan yang seharusnya tersedia di fasilitas tersebut. Ini berarti hampir setengah dari fasilitas primer tidak sepenuhnya siap secara SDM untuk memberikan layanan lengkap yang diperlukan masyarakat (WHO, 2016a).

Distribusi tenaga kesehatan juga masih timpang, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil (WHO, 2025b).

WHO mencatat bahwa banyak komunitas di daerah rural masih kekurangan tenaga kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam manajemen penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Selain itu, banyak Puskesmas masih belum memiliki infrastruktur dan sarana yang memadai sesuai standar pelayanan. Studi literatur menunjukkan 47,1% fasilitas tidak memenuhi standar prasarana dan lebih dari 50% tidak memiliki alat kesehatan esensial yang diperlukan (Laeli, 2024). Kekurangan ini membatasi kemampuan fasilitas primer untuk memberikan layanan yang efektif dan berkualitas (WHO, 2020a).

Akses masyarakat terhadap pelayanan primer juga belum merata. Kendala geografis, seperti jarak ke fasilitas dan keterbatasan transportasi, menurunkan pemanfaatan layanan di wilayah terpencil (Syed et al., 2014). Hal ini menghasilkan ketidaksetaraan dalam pencapaian layanan kesehatan yang berdampak pada derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Faktor struktural lain adalah organisasional dan pembiayaan (Mseke et al., 2024). Banyak Puskesmas masih beroperasi dengan struktur berbasis program vertikal, yang menyulitkan koordinasi layanan lintas unit seperti kesehatan ibu & anak, gizi, dan penyakit tidak menular (Rajan et al., 2024) (Ching et al., 2023). Sistem pembiayaan dan alokasi anggaran juga belum sepenuhnya mendukung integrasi layanan yang dibutuhkan untuk implementasi PHC yang efektif (Kemenkes RI, 2021).

Tantangan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer penting untuk dibahas karena pelayanan primer adalah fondasi tercapainya universal health coverage (UHC), tujuan utama sistem kesehatan modern yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (Molina-Gil et al., 2024). Peningkatan performa layanan primer berkontribusi langsung pada penurunan kesakitan, peningkatan pencegahan penyakit, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Ketidaksiapan fasilitas primer dalam SDM, infrastruktur, dan akses menunjukkan bahwa sistem kesehatan belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata (WHO, 2024b). Lebih jauh, tantangan ini memiliki implikasi besar terhadap manajemen penyakit kronis, pencegahan komplikasi, serta penurunan beban fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang lebih mahal dan kompleks (Ching et al., 2023). Dengan memahami besaran masalah ini berdasarkan data dan laporan terkini, pembahasan dalam buku ini akan membantu menyusun strategi praktik tenaga kesehatan yang realistis dan berkelanjutan untuk memperbaiki pelayanan primer di Indonesia.

B. Konsep Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan

Pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan adalah pendekatan yang sangat penting dalam sistem kesehatan modern, khususnya di fasilitas kesehatan primer (Kemenkes, 2024e). Konsep ini bertujuan untuk

mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pencegahan hingga perawatan jangka panjang, dalam satu kesatuan yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pasien. Dalam praktiknya, layanan yang terpadu tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi, tetapi juga memperhatikan kontinuitas layanan antara berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, sehingga pasien tidak merasa terputus dalam perawatan (Laeli, 2024).

Topik ini akan mengulas secara mendalam konsep pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan, yang mencakup prinsip-prinsip dasar, keuntungan yang dapat diperoleh dari pendekatan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya di fasilitas kesehatan primer. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting, karena akan membantu tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan berfokus pada kebutuhan pasien.

C. Gambaran Umum Fasilitas Kesehatan Primer

Fasilitas kesehatan primer (FKTP) adalah layanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi sebagai kontak awal masyarakat dengan sistem kesehatan, sekaligus tempat pelayanan dasar yang paling dekat dengan komunitas. Dalam konteks Indonesia, Puskesmas didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan penekanan pada promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (WHO, 2020b).

Secara global, WHO menekankan bahwa *Primary Health Care* (PHC) adalah pendekatan *whole-of-society* untuk memperkuat sistem kesehatan dengan membawa layanan kesehatan dan kesejahteraan lebih dekat ke masyarakat. Deklarasi Astana juga menegaskan penguatan *primary care* sebagai *first contact* dengan layanan kesehatan, memprioritaskan fungsi kesehatan masyarakat esensial, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan sepanjang daur hidup. Karakter utama layanan primer yang bermutu sering dirangkum sebagai 4C: *first-contact access* (akses kontak pertama), *continuity* (kesinambungan), *comprehensiveness* (komprehensif), dan *coordination* (koordinasi) (WHO, 2020b). Keempatnya membantu pasien tidak “terputus” saat berpindah layanan, dan membantu faskes primer menjalankan peran pengampu rujukan. Di Puskesmas, fungsi ini tampak dari mandat

pelayanan yang mencakup UKM esensial (misalnya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA-KB, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit) serta UKP (rawat jalan, gawat darurat, one day care, home care, dan rawat inap sesuai kebutuhan) (WHO, 2024a).

Pelayanan di faskes primer dijalankan oleh tim tenaga kesehatan dan jejaring layanan. Regulasi menekankan perlunya manajemen Puskesmas, pelayanan kefarmasian, keperawatan kesehatan masyarakat, serta laboratorium, dan dukungan jaringan pelayanan (misalnya Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, bidan desa) serta jejaring fasilitas (klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium) untuk memperkuat akses dan sistem rujukan. Selain itu, Puskesmas juga diberi kewenangan untuk melakukan komunikasi-informasi-edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta bekerja sama lintas sektor, yang menguatkan pendekatan terpadu dan berkesinambungan.

D. Pelayanan Terpadu dan Berkesinambungan

1. Pelayanan terpadu (Integrated care)

Pelayanan terpadu di fasilitas kesehatan primer berarti pengelolaan dan pemberian layanan yang membuat orang memperoleh rangkaian layanan yang utuh (promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, manajemen penyakit, rehabilitasi, hingga paliatif) secara terkoordinasi sesuai kebutuhan sepanjang hidup (WHO, 2015b). Pelayanan terpadu juga menuntut integrasi antar profesi (kolaborasi dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi, sanitarian, kader) dalam tim yang saling berbagi peran, dan integrasi antar tingkat layanan (primer–sekunder–tersier) lewat sistem rujukan serta counter-referral yang jelas sehingga pasien tidak kehilangan kesinambungan setelah pulang dari rumah sakit (Carron et al., 2021).

a. Integrasi antar program (KIA, PTM, TB, gizi, kesehatan jiwa, lansia, imunisasi).

Integrasi antar program di fasilitas kesehatan primer berarti layanan tidak berjalan “terpisah-pisah” (misalnya KIA, PTM, TB, gizi, kesehatan jiwa, lansia, imunisasi), tetapi disatukan dalam alur pelayanan yang saling terhubung sesuai kebutuhan pasien dan siklus hidup, sehingga skrining, edukasi, tatalaksana, rujukan, dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih efisien serta mengurangi missed opportunity (contoh: saat kunjungan KIA sekaligus skrining faktor risiko PTM dan konseling gizi) (WHO, 2018a).

Di Indonesia, Permenkes No. 19 Tahun 2024 menegaskan Puskesmas sebagai fasyankes tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerja, serta mengatur model layanan berbasis klaster (KIA; dewasa dan lanjut usia; penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; serta dukungan lintas klaster) yang secara praktis mendorong integrasi lintas program dan lintas sasaran (Kemenkes, 2024d). Prinsip ini juga tampak pada arahan peningkatan koordinasi lintas program dan integrasi layanan, termasuk penekanan dukungan program seperti tuberkulosis, gizi, kesehatan jiwa, dan imunisasi. Secara global, WHO memposisikan layanan terpadu berpusat pada manusia sebagai layanan yang komprehensif, terkoordinasi sepanjang kontinum perawatan, dan sesuai kebutuhan sepanjang daur hidup, sementara kerangka PHC WHO menekankan primary care sebagai proses yang mendukung layanan first-contact, berkelanjutan, komprehensif, dan terkoordinasi (WHO, 2018a).

- b. Integrasi antar profesi (interprofessional collaboration). Integrasi antar profesi di fasilitas kesehatan primer adalah cara kerja layanan yang menempatkan dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi, sanitarian, dan profesi lain sebagai satu tim yang berbagi tujuan, informasi, dan keputusan klinis agar pelayanan pasien menjadi lebih terpadu dan tidak terfragmentasi (WHO, 2016b). WHO menekankan bahwa penguatan sistem kesehatan berbasis prinsip primary health care sangat mendesak, dan salah satu solusi yang menjanjikan untuk menghadapi krisis SDM kesehatan serta layanan yang terpecah adalah kolaborasi interprofesional. Dalam kerangka layanan berpusat pada manusia (*integrated people-centred care*), kolaborasi ini membantu layanan menjadi lebih responsif dan terkoordinasi sepanjang alur perawatan, karena hubungan dan komunikasi antara pasien, penyedia layanan, serta sistem kesehatan dibangun secara jangka panjang (WHO, 2024a).
- Secara kompetensi, IPEC merumuskan kemampuan inti kolaborasi interprofesional yang relevan untuk praktik sehari-hari, meliputi nilai dan etika, peran dan tanggung jawab, komunikasi, serta tim dan kerja tim. Bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional di layanan primer dapat efektif pada berbagai konteks, walaupun karakteristik proses dan implementasinya masih perlu terus diperkuat agar manfaatnya konsisten (IPEC, 2023).

c. Integrasi antar tingkat layanan (primer–sekunder–tersier).

Integrasi antar tingkat layanan (primer–sekunder–tersier) di fasilitas kesehatan primer pada dasarnya bekerja seperti “jalur estafet” klinis: faskes primer menjadi pintu masuk dan pengampu koordinasi, lalu pasien dirujuk ke layanan yang lebih mampu (sekunder/tersier) bila kebutuhan klinis melebihi kapasitas primer, dan setelah tindakan/penanganan lanjutan pasien perlu rujuk balik (*counter-referral*) ke layanan primer untuk kontrol, pemantauan jangka panjang, edukasi, dan kesinambungan terapi (Kemenkes, 2024d). WHO menekankan bahwa sistem yang kuat membutuhkan rujukan dan rujuk balik yang berfungsi, didukung panduan rujukan, formulir rujukan standar, serta komunikasi dua arah agar informasi klinis tidak “putus di tengah jalan” dan pasien tidak tersesat antar fasilitas. Dalam konteks Indonesia, penguatan jejaring layanan primer juga menegaskan peran Puskesmas sebagai koordinator jejaring, termasuk jejaring berbasis Sistem Rujukan yang mencakup rujukan vertikal, horizontal, dan rujuk balik, serta pencatatan–pelaporan terintegrasi dan koordinasi berkala. Kerangka regulasi rujukan layanan perorangan juga diperbarui melalui Permenkes No. 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (menggantikan Permenkes No. 001 Tahun 2012), yang menguatkan tata kelola rujukan

sebagai bagian dari integrasi layanan lintas tingkat (Kemenkes, 2024c).

2. Pelayanan berkesinambungan (*Continuity of care*)

- a. *Continuity* relasional: pasien punya tenaga kesehatan “tetap”/tim yang mengenal riwayat.

Continuity relasional adalah kesinambungan yang lahir dari hubungan terapeutik yang berkelanjutan antara pasien dengan tenaga kesehatan (atau tim) yang sama, sehingga pasien merasa “ditangani oleh orang yang mengenal saya” dari waktu ke waktu. Relasi yang stabil ini membangun kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan memudahkan tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis yang lebih tepat karena memahami riwayat, preferensi, dan konteks personal pasien (WHO, 2020b).

- b. *Continuity* informasional: rekam medis dan data pasien mengalir.

Continuity informasional berarti keputusan dan tindakan layanan saat ini didukung oleh informasi dari kontak layanan sebelumnya (misalnya rekam medis, hasil pemeriksaan, riwayat obat, faktor sosial, dan rencana edukasi), sehingga layanan terasa tersambung meskipun pasien datang pada hari yang berbeda atau bertemu petugas yang berbeda. Di layanan primer, kesinambungan informasional sangat bergantung pada kualitas pencatatan dan aliran data, termasuk komunikasi rujukan dan rujuk balik yang memastikan

informasi klinis tidak “hilang” ketika pasien berpindah fasilitas (WHO, 2022b).

- c. Continuity manajerial: rencana asuhan, follow-up, monitoring.

Continuity manajerial adalah kesinambungan yang tampak ketika pasien memperoleh pendekatan penatalaksanaan yang konsisten dan terarah melalui rencana asuhan, jadwal kontrol, tindak lanjut, dan monitoring yang jelas, terutama pada kasus kronis atau multi-masalah. Dengan continuity manajerial, layanan primer mengatur jalur perawatan (*care pathway*) agar tetap koheren meski melibatkan banyak layanan atau perubahan kondisi, dan ini sangat terkait dengan koordinasi lintas profesi serta lintas fasilitas (WHO, 2018a).

E. Peta Tantangan Pelayanan di Faskes Primer

1. Tantangan Internal Faskes Primer

a. SDM & kompetensi

Tantangan SDM di faskes primer biasanya muncul dalam bentuk kekurangan atau distribusi tenaga yang tidak merata, beban kerja tinggi, serta kesenjangan kompetensi (misalnya manajemen kasus kronis, komunikasi terapeutik, dan koordinasi rujukan) yang pada akhirnya membuat layanan sulit konsisten dan menyulitkan penerapan pelayanan yang terpadu serta berkesinambungan; karena itu, penguatan perencanaan, retensi, dan peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan menjadi kunci agar layanan primer dapat menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan komprehensif secara stabil (WHO, 2020b).

- 1) Kekurangan tenaga, beban kerja tinggi, *task shifting* tanpa dukungan pelatihan.

Di fasilitas kesehatan primer, kekurangan tenaga sering membuat beban kerja melonjak sehingga waktu layanan per pasien makin sempit; dalam kondisi ini, *task shifting* (alih tugas) kerap dilakukan agar layanan tetap berjalan, tetapi bila tidak disertai pelatihan, supervisi, dan standar kompetensi yang jelas, risikonya adalah variasi mutu, kesalahan prosedur, dan layanan yang kurang konsisten dari kunjungan ke kunjungan (Carron et al., 2021).

- 2) Variasi kompetensi klinis, komunikasi, dan manajemen kasus kronis.

Situasi tersebut makin menantang ketika terdapat variasi kompetensi antar petugas, baik pada keterampilan klinis, komunikasi, maupun manajemen kasus penyakit kronis (misalnya edukasi obat, monitoring rutin, dan tindak lanjut), yang dapat menyebabkan pasien kronis mudah “putus kontrol”, rujukan tidak terkoordinasi, dan kesinambungan asuhan melemah, padahal kebutuhan pasien primer semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang kuat (WHO, 2015b).

b. Manajemen layanan & mutu

Tantangan manajemen layanan dan mutu di faskes primer sering terlihat dari SOP yang tidak konsisten dijalankan, mekanisme audit mutu yang lemah, serta budaya keselamatan pasien yang belum kuat, sehingga terjadi variasi praktik, keterlambatan layanan, atau kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah (Kemenkes RI, 2015); padahal mutu dan keselamatan adalah fondasi layanan primer untuk memastikan setiap kontak layanan menghasilkan perbaikan kesehatan, bukan sekadar “pelayanan selesai hari ini” tanpa tindak lanjut.

1) SOP ada tapi implementasi tidak konsisten.

Di banyak fasilitas kesehatan primer, SOP sebenarnya sudah tersedia, tetapi penerapannya sering tidak konsisten karena variasi beban kerja, perbedaan kompetensi (Kemenkes, 2015), dan lemahnya mekanisme pengawasan serta umpan balik, sehingga praktik pelayanan bisa berbeda antar petugas maupun antar hari (WHO, 2022a).

2) Audit klinis, indikator mutu, dan budaya keselamatan pasien belum kuat.

Audit klinis yang tidak rutin dilakukan dan indikator mutu tidak dipakai sebagai “kompas” perbaikan, maka penyimpangan dari standar sulit terdeteksi, sulit dibuktikan dengan data, dan akhirnya perbaikan berjalan sporadis (WHO, 2022a); padahal WHO menekankan audit klinis sebagai cara penting untuk mendukung implementasi standar/pedoman dan meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan. Di

saat yang sama, budaya keselamatan pasien yang belum kuat (misalnya pelaporan insiden dan pembelajaran belum berjalan) membuat risiko keselamatan cenderung “sunyi”, sehingga masalah yang sama mudah berulang; WHO juga menyediakan kerangka penilaian keselamatan pasien di layanan primer untuk membangun kapasitas staf dan mengintegrasikan praktik keselamatan secara sistematis. Di Indonesia, penguatan mutu dan keselamatan pasien di tingkat primer juga ditegaskan dalam regulasi akreditasi Puskesmas yang menuntut penggunaan indikator mutu klinis dan keselamatan pasien serta tindak lanjut perbaikan (WHO, 2023c).

c. Sarana prasarana & logistik

- 1) Ketersediaan alat, ruang layanan, dan obat esensial. Ketersediaan alat, ruang layanan, dan obat esensial merupakan prasyarat agar layanan primer mampu melakukan skrining, diagnosis, terapi, serta tindak lanjut secara aman dan bermutu (WHO, 2015a); ketika sarana tidak memadai atau obat esensial tidak tersedia, konsekuensinya sering berupa keterlambatan layanan, rujukan yang meningkat, perubahan regimen terapi yang tidak ideal, dan terganggunya kesinambungan asuhan terutama pada pasien penyakit kronis (Adhikari et al., 2024). Kerangka regulasi Indonesia menegaskan bahwa Puskesmas harus didukung sarana-prasarana serta

alat kesehatan yang jenis dan jumlahnya mengacu pada standar yang ditetapkan Menteri, sehingga ketersediaan fasilitas menjadi bagian dari tata kelola layanan primer (WHO, 2024a).

2) Sistem pengadaan dan stok yang tidak stabil (*stock-out*).

Di sisi obat, standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas mengatur pengelolaan sediaan farmasi termasuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, yang secara langsung bertujuan menjaga ketersediaan obat dan penggunaan obat yang rasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengadaan dan manajemen stok yang tidak stabil dapat memicu stock-out (Kemenkes, 2016); WHO menyoroti bahwa kekurangan dan stock-out obat esensial merupakan masalah global yang meningkat dan dapat mengganggu layanan klinis, sementara kajian ilmiah terbaru juga menunjukkan bahwa hambatan pengadaan serta sistem persediaan berperan penting dalam terjadinya kekosongan obat (Sinsky et al., 2016).

d. Sistem informasi & dokumentasi

- 1) Rekam medis belum terintegrasi, pencatatan ganda, data kurang valid.

Di fasilitas kesehatan primer, rekam medis yang belum terintegrasi sering memicu pencatatan ganda (misalnya catatan kertas lalu diketik ulang ke sistem) dan membuat validitas data menurun karena perbedaan versi catatan, keterlambatan input, atau elemen klinis yang tidak lengkap; padahal regulasi Indonesia menegaskan bahwa pengisian informasi klinis harus lengkap dan jelas, serta pada fasyankes dengan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi dalam satu dokumen agar kesinambungan asuhan terjaga (Kemenkes, 2024d).

- 2) Keterbatasan internet/ perangkat.

Tantangan ini diperberat oleh keterbatasan internet dan perangkat, sehingga sistem elektronik sulit berjalan stabil, pertukaran data antar unit/rujukan tersendat, dan beban kerja dokumentasi meningkat; WHO menempatkan ICT dan enabling environment (termasuk infrastruktur, standar, dan interoperabilitas) sebagai lapisan fondasional keberhasilan implementasi intervensi kesehatan digital (WHO, 2023e). Literatur juga menunjukkan bahwa kurangnya interoperabilitas dapat menyebabkan rekam pasien terfragmentasi dan menambah waktu klinisi untuk

mengakses/menyelaraskan informasi, sementara praktik dokumentasi yang berulang menambah beban dokumentasi dan mengganggu alur kerja klinis (WHO, 2022b).

e. Koordinasi internal & kolaborasi antar profesi

Koordinasi internal yang lemah dan kolaborasi antar profesi yang belum efektif dapat menyebabkan layanan terfragmentasi, rencana asuhan tidak selaras, dan tindak lanjut tidak konsisten (IPEC, 2023); sebaliknya, kolaborasi interprofesional membantu tim faskes primer menyatukan tujuan, membagi peran secara jelas, serta memastikan keputusan klinis dan edukasi pasien berjalan searah, yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan terpadu dan berkesinambungan (WHO, 2023d).

2. Tantangan Eksternal (Sistem & Kebijakan)

a. Pembiayaan & skema klaim

Dalam pelayanan kesehatan primer, desain pembiayaan (misalnya kapitasi, standar tarif, dan mekanisme klaim) sangat memengaruhi perilaku layanan karena ia menentukan ruang gerak klinis dan beban administratif fasilitas. Ketika tarif, insentif, dan aturan pembayaran tidak selaras dengan kompleksitas kasus (misalnya pasien kronis multimorbid), fasilitas cenderung tertekan untuk mengejar kepatuhan administrasi, menghemat waktu konsultasi, atau mendorong rujukan lebih cepat, sehingga tujuan layanan primer yang komprehensif dan

berkesinambungan menjadi lebih sulit tercapai. Regulasi Indonesia menetapkan standar tarif JKN termasuk pelayanan di FKTP (dengan mekanisme seperti kapitasi) dan pembaruan aturan jaminan kesehatan, yang menunjukkan bahwa pembiayaan memang instrumen kebijakan utama untuk mengarahkan mutu dan efisiensi layanan primer (Kemenkes, 2023).

b. Sistem rujukan

Sistem rujukan yang kuat adalah “rel penghubung” antara layanan primer dan layanan lanjutan, tetapi tantangannya sering muncul saat terjadi rujukan tidak tepat indikasi, rujuk-balik tidak berjalan, dan informasi rujukan tidak lengkap, yang berujung pada antrean di fasilitas lanjutan serta terputusnya kesinambungan asuhan (Kemenkes, 2024b). Indonesia telah mengatur sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan termasuk jenis rujukan (vertikal, horizontal, dan rujuk balik), dan juga menerbitkan pedoman rujuk balik penyakit kronis agar pasien stabil dapat kembali ditangani di FKTP melalui sistem informasi terintegrasi. Secara konseptual, WHO menekankan bahwa kesinambungan dan koordinasi perawatan sangat bergantung pada mekanisme rujukan dan counter-referral yang jelas serta pertukaran informasi dua arah (Kemenkes, 2024c).

c. Regulasi & beban administratif

Tantangan eksternal lain yang menonjol adalah “tarikan gravitasi” regulasi dan pelaporan: semakin banyak kewajiban dokumentasi, input data, dan pelaporan program, semakin besar risiko waktu klinis bergeser dari pasien ke administrasi. Bukti studi time-and-motion menunjukkan porsi signifikan waktu dokter di layanan rawat jalan terserap untuk pekerjaan rekam medis/desk work dibanding tatap muka klinis, sehingga beban administratif berpotensi menurunkan waktu komunikasi, edukasi, dan tindak lanjut yang justru krusial di layanan primer. WHO juga menekankan bahwa intervensi digital harus dirancang agar memperkuat sistem (bukan menambah beban kerja), sementara regulasi nasional tertentu bahkan mensyaratkan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi, yang bila infrastruktur dan SDM pendukung belum siap dapat memperberat workload (Sinsky et al., 2016).

d. Jejaring & lintas sektor

Layanan primer idealnya tidak bekerja sendirian, karena determinan kesehatan banyak berada di luar klinik (pendidikan, pekerjaan, lingkungan, perlindungan sosial). Ketika jejaring lintas sektor dengan desa/kelurahan, sekolah, tempat kerja, dan organisasi komunitas belum solid, program promotif-preventif (misalnya pencegahan PTM, kesehatan jiwa komunitas, gizi, sanitasi) kehilangan daya ungkit, sehingga beban kasus kembali menumpuk di fasilitas.

WHO menempatkan multisectoral policy and action sebagai komponen inti primary health care bersama penguatan layanan primer dan pemberdayaan masyarakat, dan kajian realistis tentang aksi multisektoral menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memengaruhi keberhasilan implementasi PHC menuju UHC, terutama pada konteks sistem yang kompleks (WHO, 2020b).

3. Tantangan Pasien & Komunitas

Pada layanan kesehatan primer, tantangan dari sisi pasien dan komunitas sering terbentuk sebagai “rantai” yang saling menguatkan: akses dan kesetaraan dapat terganggu oleh hambatan geografis dan finansial sehingga layanan tidak diterima tepat waktu dan tepat tempat (Mseke et al., 2024); literasi kesehatan dan kepatuhan memengaruhi pemahaman obat serta keberlanjutan kontrol; budaya, stigma, dan isu sensitif menahan pasien untuk mencari pertolongan atau membuka masalah secara aman; lalu pergeseran beban penyakit menuju PTM, multimorbiditas, penuaan, dan masalah kesehatan jiwa membuat kebutuhan layanan menjadi makin kompleks dan memerlukan tindak lanjut jangka panjang (WHO, 2025a).

a. Akses & kesetaraan layanan

Jarak dan waktu tempuh yang jauh terbukti menurunkan keterjangkauan layanan, terutama pada wilayah rural/remote, karena meningkatkan “biaya” kunjungan (waktu, tenaga, dan risiko tertunda), yang

pada akhirnya dapat menurunkan penggunaan layanan primer dan memperburuk keterlambatan penanganan. Hambatan transportasi (ketersediaan kendaraan, rute, ongkos, dan keamanan perjalanan) sering menjadi penghalang besar untuk hadir ke fasilitas kesehatan, bahkan dilaporkan berdampak luas pada berbagai kelompok populasi (Mseke et al., 2024); ketika transport sulit, pasien cenderung menunda kunjungan, melewati kontrol, atau hanya datang saat kondisi memburuk. Selain biaya layanan, biaya tidak langsung seperti ongkos transport dan potensi kehilangan pendapatan selama berobat dapat menciptakan financial barrier yang membuat pasien menunda atau menghindari layanan, terutama pada keluarga rentan (Kemenkes RI, 2017); hal ini selaras dengan konsep UHC bahwa akses harus terjadi “tanpa kesulitan finansial”, karena pembayaran dari kantong sendiri dan beban biaya dapat mengganggu kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan esensial lainnya. Jam layanan yang tidak sesuai kebutuhan pasien (misalnya terbatas pada jam kerja) dapat menurunkan akses “in-hours”, memicu penggunaan layanan di luar jam kerja, dan meningkatkan risiko pasien memilih alternatif yang kurang tepat (misalnya datang ke IGD untuk masalah yang bisa ditangani di layanan primer) (WHO, 2025b); bukti menunjukkan aspek organisasi akses, termasuk ketersediaan janji temu pada waktu yang tepat,

berhubungan dengan pola pemanfaatan layanan. Pada penyandang disabilitas, hambatan akses kerap terjadi pada level fisik (akses bangunan), komunikasi (informasi dan interaksi) (Malikhao, 2020), serta sikap dan kompetensi layanan, sehingga kesetaraan layanan berkurang; WHO menekankan pentingnya akses yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas, sementara tinjauan ilmiah menunjukkan hambatan yang berulang pada sumber daya, pelatihan tenaga, dan pengaturan sistem layanan (WHO, 2024a).

b. Literasi kesehatan & kepatuhan

Literasi kesehatan memengaruhi kemampuan pasien mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan, sehingga berpengaruh langsung pada penggunaan obat yang benar; bukti telaah sistematis menunjukkan literasi kesehatan merupakan faktor penting yang terkait dengan kepatuhan minum obat, khususnya pada pasien dengan polifarmasi (WHO, 2025a). Putus kontrol atau lost to follow-up pada penyakit kronis merupakan masalah bermakna karena tindak lanjut jangka panjang adalah inti pengendalian komplikasi; tinjauan scoping menunjukkan berbagai faktor berkontribusi terhadap LTFU di layanan rawat jalan, dan studi tentang ketidakhadiran janji temu menggambarkan bahwa missed appointments dapat mengganggu kesinambungan layanan dan hasil klinis (Ching et al., 2023). Doctor shopping (berobat ke banyak

dokter/fasilitas untuk keluhan yang sama atau mencari resep) dapat memecah informasi klinis, memicu duplikasi terapi/pemeriksaan, dan mengganggu koordinasi layanan primer; literatur mendefinisikannya sebagai perilaku mengunjungi beberapa penyedia layanan dalam satu episode penyakit, dan telaah sistematis menyoroti variasi motif serta dampaknya bagi pasien maupun sistem pembiayaan. Penggunaan obat tanpa resep, terutama antibiotik, berisiko meningkatkan penggunaan tidak rasional, efek samping, dan resistansi antimikroba; WHO menegaskan AMR membuat infeksi makin sulit diobati, dan bukti ilmiah menunjukkan konsumsi antimikroba tanpa resep merupakan faktor risiko penting bagi AMR (WHO, 2023a).

c. Budaya, stigma, dan isu sensitif

Stigma dan diskriminasi pada kesehatan jiwa dapat menunda pencarian pertolongan, memperlebar treatment gap, dan menurunkan kualitas luaran karena pasien enggan mengakses layanan atau takut pelabelan sosial; WHO juga menekankan bahwa banyak orang dengan gangguan mental tidak mendapatkan perawatan efektif, salah satunya terkait stigma dan diskriminasi (WHO, 2024d). Stigma TB dapat menyebabkan pasien menunda pemeriksaan, menutup status penyakit, atau mengalami konsekuensi sosial (misalnya masalah pekerjaan/sekolah), yang akhirnya mengganggu keberhasilan pengobatan;

WHO menggarisbawahi perlunya perlindungan dari stigmatisasi dan diskriminasi dalam layanan TB, dan studi juga mengidentifikasi stigmatisasi sebagai salah satu penghalang utama keberhasilan terapi TB (WHO, 2024c). Pada HIV, stigma dan diskriminasi menghambat respons HIV di berbagai tahap, mulai dari akses layanan hingga luaran terapi, termasuk retensi dan kepatuhan; UNAIDS menekankan bahwa stigma membatasi akses layanan dan berhubungan dengan luaran pengobatan yang lebih buruk, dan bukti ilmiah juga menunjukkan stigma memengaruhi testing, perawatan, serta kepatuhan. KDRT atau intimate partner violence adalah isu sensitif yang sering tidak terungkap karena takut, stigma, dan ketergantungan sosial-ekonomi, padahal dampaknya besar terhadap kesehatan fisik dan mental (misalnya depresi, PTSD, dan gangguan kesehatan reproduksi); WHO menegaskan konsekuensi kesehatan yang luas dan menunjukkan pentingnya respons layanan yang aman, rahasia, dan terhubung dengan dukungan sosial (UNAIDS, 2024)

d. Beban penyakit berubah

Beban penyakit global telah bergeser dengan dominasi PTM, yang menyumbang proporsi terbesar kematian dan membutuhkan pengelolaan jangka panjang di layanan primer; karena itu, kapasitas layanan primer untuk skrining, terapi, edukasi, dan kontrol rutin menjadi penentu utama kendali populasi atas PTM

(WHO, 2025d). Multimorbiditas (dua atau lebih kondisi kronis) meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan klinis, risiko polifarmasi, dan kebutuhan koordinasi, sehingga mudah terjadi fragmentasi bila sistem rujukan dan dokumentasi lemah; WHO menekankan bahwa penuaan populasi dan meningkatnya kondisi jangka panjang akan menaikkan multimorbiditas, dengan implikasi khusus terhadap keselamatan pasien di layanan primer. Pada kelompok lansia, kebutuhan layanan meningkat karena kecenderungan memiliki beberapa kondisi sekaligus (misalnya diabetes, COPD, depresi, demensia), sehingga layanan primer perlu fokus pada perawatan berkelanjutan, pencegahan komplikasi, dan dukungan fungsi; WHO menegaskan bahwa seiring bertambah usia, seseorang lebih mungkin mengalami beberapa kondisi kesehatan secara bersamaan (WHO, 2016c). Masalah kesehatan jiwa merupakan beban yang besar dan cenderung meningkat pada situasi krisis, dengan data WHO menunjukkan prevalensi gangguan mental yang tinggi secara global serta peningkatan signifikan kecemasan dan depresi pada masa pandemi; implikasinya bagi layanan primer adalah kebutuhan skrining, tatalaksana dasar, rujukan yang aman, serta pengurangan stigma di komunitas (WHO, 2025c).

F. Dampak Tantangan terhadap Layanan

Secara keseluruhan, tantangan di layanan primer dapat menurunkan mutu klinis (diagnosis terlambat, tatalaksana bervariasi), menaikkan risiko keselamatan pasien (terutama medication error dan tindak lanjut yang gagal), memutus kontinuitas layanan (drop-out pasien kronis dan rujuk-balik yang tidak “menutup lingkaran”) (Kemenkes, 2024c), melemahkan kepuasan pasien (waktu tunggu panjang, komunikasi kurang efektif, trust turun), dan akhirnya menggerus efisiensi sistem (rujukan menumpuk dan biaya meningkat). Lima dampak ini saling terkait: ketika standar mutu dan keselamatan melemah, kontinuitas dan kepuasan ikut turun, lalu sistem membayar “biaya lanjutan” melalui rujukan dan penggunaan layanan yang lebih mahal.

1. Mutu klinis: keterlambatan diagnosis, tatalaksana tidak standar.

Tantangan di layanan primer dapat menurunkan mutu klinis ketika proses pelayanan tidak lagi mampu memastikan diagnosis dan tatalaksana berbasis bukti berjalan konsisten, sehingga hasil kesehatan pasien menjadi kurang optimal. Secara konseptual, mutu layanan mencerminkan sejauh mana layanan kesehatan meningkatkan peluang luaran yang diinginkan dan selaras dengan pengetahuan profesional berbasis bukti, sehingga gangguan mutu di layanan primer akan mudah “terakumulasi” menjadi masalah populasi (misalnya keterlambatan deteksi dini dan pengendalian penyakit kronis). Implikasi (keterlambatan diagnosis, tatalaksana tidak standar): Keterlambatan diagnosis di layanan primer

sering dipengaruhi kombinasi faktor sistem (akses pemeriksaan, alur rujukan, beban kerja), faktor klinisi (kognitif dan komunikasi), dan faktor pasien, yang akhirnya meningkatkan risiko progresi penyakit dan kebutuhan layanan lanjutan. Di saat yang sama, tatalaksana yang tidak standar biasanya terjadi ketika pedoman klinis dan SOP tidak diikuti secara seragam, dan tanpa audit klinis yang rutin, deviasi dari standar sulit terdeteksi sehingga variasi praktik bertahan lama (Singh et al., 2017).

2. Keselamatan pasien: medication error, follow-up gagal.

Ketika sistem layanan primer berada dalam tekanan (SDM, logistik, dokumentasi, koordinasi), risiko kejadian tidak diharapkan meningkat karena keselamatan pasien sangat bergantung pada proses yang andal, komunikasi yang jelas, dan manajemen risiko yang aktif. WHO menekankan bahwa sebagian besar kejadian yang membahayakan pasien dapat dicegah, dan area yang sering memicu harm mencakup proses perawatan, komunikasi, serta penggunaan obat. Implikasi (medication error, follow-up gagal): Medication error adalah kejadian yang dapat dicegah dan dapat menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien; WHO menyoroti bahwa faktor penyebabnya bisa berasal dari tenaga kesehatan, pasien, lingkungan kerja, maupun sistem obat, termasuk di pelayanan primer. Kegagalan follow-up (tindak lanjut tidak terjadi atau tidak tepat waktu) sering muncul saat

informasi klinis terputus, penjadwalan kontrol lemah, atau transisi rujukan tidak tertutup dengan rujuk-balik yang jelas, sehingga kondisi pasien dapat memburuk tanpa terdeteksi (WHO, 2022a).

3. Kontinuitas layanan: drop-out pasien kronis, rujuk-balik tidak efektif.

Kontinuitas layanan merupakan inti layanan primer, karena penyakit kronis, masalah kesehatan jiwa, dan kondisi kompleks membutuhkan perawatan yang “nyambung” dari waktu ke waktu. Secara ilmiah, kontinuitas dipahami sebagai rangkaian layanan yang koheren, mencakup dimensi relasional, informasional, dan manajerial; ketika dimensi ini melemah, layanan menjadi terfragmentasi dan dampaknya terasa pada luaran pasien serta beban sistem. Implikasi (drop-out pasien kronis, rujuk-balik tidak efektif): Drop-out pada pasien kronis (misalnya putus kontrol) membuat monitoring target klinis dan pencegahan komplikasi tidak berjalan, sehingga risiko perburukan dan kunjungan gawat darurat meningkat. Rujuk-balik yang tidak efektif memperpanjang transisi layanan dan menghambat kesinambungan, karena rencana perawatan, penyesuaian obat, serta target tindak lanjut tidak kembali “mendarat” di layanan primer secara jelas, padahal praktik WHO menekankan pentingnya koordinasi dua arah untuk menjaga kesinambungan (Kemenkes, 2024a)

4. Kepuasan pasien: waktu tunggu, komunikasi, kepercayaan.

Kepuasan pasien di layanan primer adalah indikator penting karena berhubungan dengan pengalaman layanan, kepercayaan, dan kemauan pasien untuk kembali kontrol, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan intervensi jangka panjang. Bukti menunjukkan bahwa pengalaman pasien dipengaruhi faktor proses layanan seperti waktu tunggu dan kualitas komunikasi, sementara mutu layanan yang berorientasi pada manusia menempatkan pengalaman pasien sebagai komponen yang perlu dikelola bersama indikator klinis. Implikasi (waktu tunggu, komunikasi, kepercayaan): Waktu tunggu yang panjang cenderung menurunkan persepsi kualitas layanan, terutama bila pasien merasa tidak mendapat informasi yang memadai selama menunggu. Namun komunikasi yang jelas, rasa dihormati, dan keterlibatan pasien dalam keputusan klinis sering menjadi penentu kuat kepuasan, dan dari situlah kepercayaan terbentuk; ketika komunikasi buruk, pasien lebih rentan tidak patuh, berpindah fasilitas, atau enggan melakukan follow-up (Malikhao, 2020).

5. Efisiensi sistem: rujukan menumpuk, biaya meningkat.

Dampak tantangan layanan primer juga terlihat pada efisiensi sistem, yaitu kemampuan sistem kesehatan menghasilkan tujuan bernilai (kesehatan, perlindungan finansial, responsivitas) dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan minim pemborosan. WHO menekankan bahwa peningkatan efisiensi berkaitan erat dengan pengurangan duplikasi, pemborosan, dan penguatan tata

kelola sumber daya, sementara pengelolaan rujukan yang “bernilai tinggi” membantu memastikan pasien mendapat layanan spesialis saat perlu tanpa menciptakan aktivitas yang tidak perlu. Implikasi (rujukan menumpuk, biaya meningkat): Jika layanan primer tidak mampu menuntaskan kasus sesuai kewenangannya (misalnya karena alat/obat/SDM/koordinasi lemah), rujukan dapat meningkat dan menumpuk di layanan lanjutan, memicu antrean serta meningkatkan biaya sistem. Literatur juga menekankan bahwa sistem rujukan yang efektif membantu penggunaan layanan rumah sakit menjadi lebih hemat biaya dan tepat sasaran, sehingga rujukan yang tidak tepat atau alur rujuk-balik yang lemah berisiko menciptakan pemborosan dan beban finansial tambahan (Kemenkes, 2024b).

G. Strategi Solusi Berbasis “Terpadu & Berkesinambungan”

Strategi solusi berbasis layanan terpadu dan berkesinambungan menekankan penataan layanan primer agar pasien menerima rangkaian layanan yang komprehensif dan terkoordinasi sepanjang perjalanan penyakit dan daur hidup, bukan sekadar kunjungan episodik. Dalam kerangka WHO tentang integrated, people-centred health services dan penguatan PHC, kuncinya adalah membangun lingkungan pelayanan yang memungkinkan koordinasi lintas program, lintas profesi, dan lintas tingkat layanan, dengan kesinambungan informasi, relasi terapeutik, serta rencana asuhan yang konsisten (termasuk rujuk-balik dan tindak

lanjut). Dengan demikian, perbaikan internal seperti kerja tim, manajemen kasus, mutu, logistik, dan komunikasi klinis menjadi “mesin” operasional agar integrasi dan kontinuitas benar-benar terjadi di lapangan.

1. Penguatan internal

- a. *Team-based care* (tim perawatan) + pembagian peran jelas.

Penguatan *team-based care* di layanan primer bertujuan memastikan pelayanan berjalan sebagai kerja tim multidisiplin yang menyediakan layanan luas secara terkoordinasi, sehingga kebutuhan pasien (terutama kronis/kompleks) ditangani menyeluruh tanpa fragmentasi. WHO menekankan bahwa komposisi tim primer dapat melibatkan dokter umum/keluarga, perawat, apoteker, kader/CHW, konselor kesehatan jiwa, ahli gizi, dan lainnya sesuai konteks; pembagian peran yang jelas membantu mengurangi duplikasi, memperkuat koordinasi, dan menjaga kontinuitas karena tugas monitoring, edukasi, dan tindak lanjut tidak “jatuh di celah” antar profesi (WHO, 2020b).

- b. **Case management** untuk pasien kronis/kompleks (misalnya perawat sebagai koordinator tindak lanjut).

Case management memperkuat kesinambungan layanan dengan menempatkan seorang koordinator (seringnya perawat/manajer kasus) untuk mengatur rencana asuhan, pemantauan berkala, navigasi rujukan, serta dukungan self-management pasien. Bukti

penelitian menunjukkan peran perawat manajemen kasus di pelayanan primer dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi pada pasien penyakit kronis, karena tindak lanjut lebih terstruktur dan respons terhadap perubahan kondisi lebih cepat, yang selaras dengan prinsip WHO tentang kontinuitas dan koordinasi perawatan (Molina-Gil et al., 2024)

- c. Standarisasi SOP + audit mutu (indikator sederhana dulu).

Standarisasi SOP memastikan tatalaksana klinis lebih seragam, namun dampak nyata biasanya muncul ketika SOP disertai audit klinis dan umpan balik yang rutin. WHO menjelaskan audit klinis sebagai penilaian terstruktur praktik terhadap standar dalam periode tertentu untuk mengidentifikasi kesenjangan, mendorong kepatuhan terhadap pedoman, dan menjadi siklus perbaikan mutu berkelanjutan; memulai dari indikator sederhana (misalnya kepatuhan skrining, kontrol tekanan darah, kepatuhan rencana follow-up) membuat sistem mutu lebih realistis diterapkan di faskes primer (Patnode et al., 2016).

- d. **Perbaikan logistik obat** (obat esensial, buffer stock).

Perbaikan logistik obat menargetkan ketersediaan obat esensial yang stabil agar layanan primer dapat memberikan terapi rasional dan berkesinambungan, terutama untuk PTM yang memerlukan konsumsi jangka panjang. WHO menekankan konsep obat esensial sebagai dasar pengadaan dan suplai yang

lebih baik; sementara laporan WHO tentang medicine shortages menunjukkan kekosongan obat meningkat dan terkait faktor rantai pasok, sehingga strategi seperti perencanaan kebutuhan, penguatan sistem persediaan, dan buffer/strategic inventory relevan untuk menurunkan risiko stock-out yang mengganggu kontinuitas terapi (Kemenkes RI, 2021).

e. Penguatan komunikasi klinis (SBAR/hand over rapi).

Penguatan komunikasi klinis, khususnya saat handover dan eskalasi kondisi, penting karena banyak insiden keselamatan pasien berakar pada komunikasi yang tidak standar dan informasi yang hilang. WHO memasukkan “komunikasi saat serah terima” sebagai solusi keselamatan pasien dan merekomendasikan kerangka terstruktur seperti SBAR (Situation–Background–Assessment–Recommendation) untuk menyamakan bahasa klinis, memperjelas prioritas, dan memastikan rencana tindak lanjut tersampaikan, sehingga risiko salah terapi, keterlambatan respons, dan putus follow-up dapat ditekan (Kingsland et al., 2021)

2. Penguatan sistem & jejaring

Penguatan sistem dan jejaring pada fasilitas kesehatan primer merupakan landasan agar pelayanan terpadu dan berkesinambungan benar-benar terjadi, karena integrasi klinis di level fasilitas tidak akan optimal tanpa dukungan mekanisme sistem yang menghubungkan pasien, data, dan alur layanan lintas

fasilitas serta lintas sektor. Kerangka Primary Health Care WHO menekankan bahwa layanan primer yang kuat membutuhkan instrumen sistem seperti tata kelola layanan, koordinasi jejaring, serta lingkungan pendukung (termasuk sistem informasi) untuk memastikan pelayanan first-contact, komprehensif, terkoordinasi, dan kontinu sepanjang perjalanan pasien. Sejalan dengan itu, WHO juga menegaskan bahwa kesinambungan dan koordinasi perawatan bergantung pada rujukan dua arah, pertukaran informasi, dan pengelolaan transisi layanan yang terencana. Dalam konteks Indonesia, penguatan ini dipertegas melalui regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan serta penguatan rekam medis (termasuk elektronik) sebagai fondasi kesinambungan informasional, sehingga rujukan, rujuk-balik, tindak lanjut, dan pengambilan keputusan klinis dapat berjalan konsisten berbasis informasi yang utuh (WHO, 2022b).

- a. **Rujuk-balik efektif:** format ringkas, jadwal kontrol, edukasi pasien.

Rujuk-balik yang efektif membuat transisi dari layanan lanjutan kembali ke layanan primer menjadi tertutup rapi: ada ringkasan klinis yang singkat namun bermakna (diagnosis kerja, terapi, target kontrol, tanda bahaya), jadwal kontrol yang jelas, serta edukasi pasien agar tahu kapan kembali dan kapan harus segera mencari pertolongan. Di Indonesia, kerangka sistem rujukan diatur dalam Permenkes tentang sistem rujukan, dan rujuk-balik penyakit kronis ditegaskan

untuk pasien yang stabil dari fasyankes tingkat lanjut ke FKTP melalui sistem informasi terintegrasi, sehingga kesinambungan terapi dan monitoring dapat berjalan di layanan primer. Prinsip ini sejalan dengan panduan WHO bahwa kesinambungan dan koordinasi perawatan bergantung pada rujukan dua arah, pertukaran informasi, dan tindak lanjut yang terencana (Kemenkes, 2024a).

- b. **Integrasi data:** minimal satu alur rekam medis yang konsisten.

Integrasi data di layanan primer menargetkan continuity informasional: informasi klinis pasien (riwayat, pemeriksaan, obat, rencana tindak lanjut) tersedia konsisten lintas kunjungan dan lintas unit layanan, sehingga keputusan klinis tidak dibuat “dari nol” setiap kali pasien datang. Regulasi rekam medis di Indonesia menekankan isi rekam medis dan memungkinkan rekam medis elektronik, namun manfaatnya baru maksimal bila ada satu alur dokumentasi yang tidak duplikatif dan mendukung pertukaran informasi yang aman. WHO juga menegaskan bahwa intervensi digital perlu dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan (termasuk tata kelola data dan proses layanan), bukan menambah beban dokumentasi (WHO, 2023e).

- c. **Kolaborasi lintas sektor:** kader, posyandu, sekolah, tokoh masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor penting karena banyak determinan kesehatan berada di luar klinik, sehingga keberhasilan promotif-preventif dan pengelolaan penyakit kronis memerlukan kemitraan dengan komunitas dan institusi lokal (kader/posyandu, sekolah, tokoh masyarakat, perangkat desa). Kerangka WHO tentang Primary Health Care menempatkan multisectoral policy and action serta pemberdayaan masyarakat sebagai komponen inti PHC, dan panduan WHO tentang community engagement menekankan keterlibatan komunitas yang terintegrasi dalam tata kelola untuk mendorong perubahan perilaku, lingkungan, dan dukungan sosial yang berkelanjutan (WHO, 2023b).

3. Pemberdayaan pasien & komunitas

Pemberdayaan pasien dan komunitas di layanan primer bertujuan memperkuat self-care dan retensi perawatan melalui tiga tuas yang saling melengkapi: edukasi berbasis literasi (bahasa sederhana, pesan tindakan yang jelas, dibantu media visual) agar pasien mampu memahami informasi kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat, pendampingan pasien kronis (misalnya pengingat kontrol, dukungan komunikasi terarah, serta edukasi kelompok) untuk menjaga kepatuhan dan kesinambungan tindak lanjut, serta intervensi anti-stigma terutama pada isu sensitif seperti kesehatan jiwa agar hambatan sosial untuk mencari pertolongan dan bertahan dalam terapi berkurang.

- a. Edukasi berbasis literasi (bahasa sederhana, media visual).

Edukasi berbasis literasi berfokus pada penyampaian informasi yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti, sehingga pasien mampu membuat keputusan sehat, menggunakan obat dengan benar, dan menjalankan self-care sesuai kondisi. WHO menegaskan bahwa health literacy adalah kunci pemberdayaan individu sekaligus memperkecil ketimpangan, sehingga materi edukasi sebaiknya memakai bahasa sederhana, struktur jelas (poin inti, langkah tindakan), serta dukungan visual untuk kelompok dengan literasi rendah atau hambatan bahasa (Landers et al., 2020).

- b. Program pendampingan pasien kronis (reminder kontrol, grup edukasi).

Pendampingan pasien kronis memperkuat kesinambungan manajerial melalui follow-up terjadwal, penguatan perilaku, dan dukungan self-management; contoh yang sering efektif adalah pengingat kontrol (SMS/telepon) serta edukasi kelompok yang melatih keterampilan mengelola penyakit (monitoring, diet/aktivitas, kepatuhan obat, dan rencana menghadapi kekambuhan). Bukti menunjukkan intervensi pengingat berbasis pesan dapat meningkatkan kepatuhan pada terapi/komitmen perawatan pada beberapa kondisi kronis, dan telaah sistematis di layanan primer menegaskan dukungan

self-management berasosiasi dengan perbaikan luaran pasien pada berbagai penyakit (Molina-Gil et al., 2024).

- c. Intervensi anti-stigma (khusus kesehatan jiwa/PTM tertentu).

Intervensi anti-stigma diperlukan karena stigma membuat pasien menunda mencari pertolongan, enggan terbuka, dan sulit bertahan dalam perawatan, terutama pada isu sensitif seperti kesehatan jiwa (dan sebagian PTM yang terkait label sosial). WHO mengembangkan Mosaic Toolkit yang menekankan prinsip tindakan berbasis bukti seperti keterlibatan orang dengan pengalaman hidup (lived experience), kontak sosial yang aman, serta kemitraan inklusif untuk mengubah norma, praktik layanan, dan kebijakan agar lebih ramah dan tidak diskriminatif; pendekatan ini membantu meningkatkan akses, retensi, serta kualitas hubungan terapeutik di layanan primer dan komunitas (WHO, 2024d).

H. Kesimpulan

Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer menghadapi tantangan yang saling berkelindan dari sisi internal, sistem eksternal, hingga pasien dan komunitas. Keterbatasan SDM dan variasi kompetensi, ketidakkonsistenan penerapan SOP serta lemahnya audit mutu, keterbatasan sarana-prasarana dan logistik obat, serta fragmentasi sistem informasi dan koordinasi tim dapat menurunkan mutu klinis dan keselamatan pasien. Pada level

eksternal, desain pembiayaan dan beban administratif, efektivitas rujukan–rujuk balik, serta kekuatan jejaring lintas sektor turut menentukan kemampuan faskes primer menjalankan fungsi kontak pertama yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Sementara itu, hambatan akses, literasi kesehatan, stigma, dan meningkatnya beban PTM serta multimorbiditas memperbesar risiko putus tindak lanjut dan menurunkan pengalaman serta kepuasan pasien, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi sistem melalui peningkatan rujukan dan biaya layanan lanjutan.

Strategi solusi yang paling relevan adalah penguatan layanan primer melalui pendekatan terpadu dan berkesinambungan yang menata pelayanan sebagai satu alur perawatan yang koheren lintas program, lintas profesi, dan lintas tingkat layanan. Implementasi praktisnya mencakup penguatan tim berbasis peran, manajemen kasus untuk pasien kronis/kompleks, standarisasi SOP dengan siklus audit mutu, stabilisasi logistik obat esensial, serta komunikasi klinis terstruktur untuk menjaga keselamatan dan follow-up. Di tingkat sistem, rujuk-balik dua arah yang efektif, integrasi data rekam medis yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor memperkuat kesinambungan asuhan. Di sisi pasien dan komunitas, edukasi berbasis literasi, pendampingan penyakit kronis, dan intervensi anti-stigma memperbaiki keterlibatan pasien dan retensi perawatan. Dengan penguatan tersebut, faskes primer berpotensi lebih optimal mencapai tujuan utama: mutu klinis yang lebih baik,

keselamatan pasien meningkat, kontinuitas layanan terjaga, kepuasan pasien membaik, dan efisiensi sistem kesehatan meningkat.

I. Referensi

- Adhikari, B., Ranabhat, K., Khanal, P., & Poudel, M. (2024). *Procurement process and shortages of essential medicines in public health facilities : A qualitative study from Nepal*. 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003128>
- Carron, T., Rawlinson, C., Arditi, C., Peytremann-bridevaux, I., & Peytremann-bridevaux, I. (2021). *An Overview of Reviews on Interprofessional Collaboration in Primary Care: Effectiveness*. 21(2), 1–14. <https://doi.org/10.5334/ijic.5588>
- Ching, T., Michelle, Y., Rui, K., Victoria, Y., & Sing, L. E. (2023). A scoping review on the factors associated with the lost to follow - up (LTFU) amongst patients with chronic disease in ambulatory care of high - income countries (HIC). *BMC Health Services Research*, 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09863-0>
- IPEC. (2023). *IPEC CORE COMPETENCIES FOR INTERPROFESSIONAL COLLABORATIVE PRACTICE : V E R S I O N 3*.
- Kemenkes. (2015). *Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi PUSKESMAS, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*.

- Kemenkes. (2016). *Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.*
- Kemenkes. (2023). *Permenkes Nomor 3 tahun 2023 Tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.* 35.
- Kemenkes. (2024a). *Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1645/2024 tentang Rujuk Balik Penyakit Kronis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.* 1–47.
- Kemenkes. (2024b). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN.*
- Kemenkes. (2024c). *Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN.*
- Kemenkes. (2024d). *Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.*
- Kemenkes. (2024e). *Permenkes tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.*
- Kemenkes RI. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayanannya. Permenkes RI,* 1–46.
- Kemenkes RI. (2017). *Buku Panduan GERMAS (Gerakan*

- Masyarakat Hidup Sehat). *Warta Kesmas*, 7(kesehatan masyarakat), 27.
- Kemenkes RI. (2021). Indonesian Ministry of Health Performance Report 2020. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021*, 1–224.
- Kingsland, M., Hollis, J., Farragher, E., Wolfenden, L., Campbell, K., Pennell, C., Reeves, P., Tully, B., Daly, J., Attia, J., Oldmeadow, C., Hunter, M., Murray, H., Paolucci, F., Foureur, M., & Rissel, C. (2021). *An implementation intervention to increase the routine provision of antenatal care addressing gestational weight gain: study protocol for a stepped-wedge cluster trial*. 1–13.
- Laeli, S. Z. (2024). *Tantangan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam Upaya Pemerataan Pelayanan Kesehatan Primer (Challenges in Implementing Health Development in Efforts to Equalize Primary Health Services)*.
- Landers, M., Hegarty, J., Saab, M. M., Savage, E., Cornally, N., Drennan, J., Bassett, G., Lunn, C., & Coffey, A. (2020). Nurses' and midwives' views of the "Leaders for Compassionate Care Program": A qualitative analysis. *Collegian*, 27(1), 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2019.03.005>
- Malikhao, P. (2020). Health communication: Approaches, strategies, and ways to sustainability on health or health for all. *Handbook of Communication for Development and Social Change*, 1015–1037. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3_137

- Molina-Gil, M. J., Guerra-Martín, M. D., & Diego-Cordero, R. De. (2024). *Primary Healthcare Case Management Nurses and Assistance Provided to Chronic Patients: A Narrative Review*. 1–12.
- Mseke, E. P., Jessup, B., & Barnett, T. (2024). Impact of distance and / or travel time on healthcare service access in rural and remote areas: A scoping review. *Journal of Transport & Health*, 37(November 2023), 101819. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101819>
- Patnode, C. D., Henninger, M. L., Senger, C. A., Perdue, L. A., & Whitlock, E. P. (2016). Evidence Synthesis Number 143 Primary Care Interventions to Support Breastfeeding: Updated Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Contract*, 4.
- Rajan, D., Rouleau, K., Winkelmann, J., Jakab, M., Kringos, D., & Khalid, F. (2024). *Implementing the primary health care approach A primer*.
- Singh, H., Schiff, G. D., Graber, M. L., Onakpoya, I., & Thompson, M. J. (2017). *The global burden of diagnostic errors in primary care*. 484–494. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005401>
- Sinsky, C., Colligan, L., Li, L., Prgomet, M., Reynolds, S., Goeders, L., Westbrook, J., Tutty, M., & Blike, G. (2016). Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties. *Annals of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.7326/M16-0961>
- Syed, S. T., Gerber, B. S., & Sharp, L. K. (2014). *Traveling*

Towards Disease: Transportation Barriers to Health Care Access. 38(5), 976–993.
<https://doi.org/10.1007/s10900-013-9681-1>.
Traveling

UNAIDS. (2024). *HIV AND STIGMA AND DISCRIMINATION*.

WHO. (2015a). *TECHNICAL CONSULTATION ON PREVENTING AND MANAGING GLOBAL STOCK OUTS OF MEDICINES*. December.

WHO. (2015b). *WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016-2026 Executive Summary services*.

WHO. (2016a). *Framework on integrated , people - centred health services*. April, 1–12.

WHO. (2016b). *Integrated people- centred care Overview*.

WHO. (2016c). *Multimorbidity*.

WHO. (2018a). *Continuity and coordination of care*.

WHO. (2018b). *Technical Series on primary health care*.

WHO. (2020a). *Operational framework for primary health care*.

WHO. (2020b). *Operational Framework for Primary Health Care*.

WHO. (2022a). *Patient safety assessment manual for primary care*.

WHO. (2022b). *Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. 1–20.

WHO. (2023a). *Antimicrobial resistance Key facts. 2030*(November).

- WHO. (2023b). *Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice*.
- WHO. (2023c). *Patient Safety*. September.
- WHO. (2023d). *Primary health care*.
- WHO. (2023e). *WHO guideline Recommendation on Digital Interventions for Health System Strengthening*.
- WHO. (2024a). *Integrated primary care for UHC Section navigation*.
- WHO. (2024b). *Quality of Care*.
- WHO. (2024c). *TB Knowledge Sharing Platform*. 6–7.
- WHO. (2024d). *The overwhelming case for ending stigma and discrimination in mental health*.
- WHO. (2025a). *Health Literacy*. December.
- WHO. (2025b). *Indonesia moves forward on universal health coverage while addressing remaining gaps*.
- WHO. (2025c). *Mental Disorders*. September.
- WHO. (2025d). *Noncommunicable diseases*. September.

J. Glosarium

A

- **Akses kontak pertama (first-contact access):** Kemampuan layanan primer menjadi pintu masuk awal masyarakat ke sistem kesehatan, mudah dijangkau saat kebutuhan kesehatan muncul.
- **Audit klinis:** Penilaian sistematis terhadap praktik klinis dibanding standar/pedoman untuk menemukan

kesenjangan dan mendorong perbaikan mutu berkelanjutan.

- **AMR (Antimicrobial Resistance / Resistansi antimikroba):** Kondisi ketika kuman menjadi kebal terhadap obat antimikroba (misalnya antibiotik), sehingga pengobatan menjadi kurang efektif.

B

- **Beban administratif:** Porsi kerja layanan (pencatatan, pelaporan, input data) yang dapat mengurangi waktu klinis untuk komunikasi, edukasi, dan tindak lanjut pasien.
- **Buffer stock:** Persediaan cadangan obat/alat untuk mencegah kekosongan saat terjadi keterlambatan pengadaan atau lonjakan kebutuhan.
- **Budaya keselamatan pasien:** Nilai, sikap, dan praktik organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas, termasuk pelaporan insiden dan pembelajaran perbaikan.

C

- **Case management (Manajemen kasus):** Pendekatan terstruktur untuk mengoordinasikan rencana asuhan, follow-up, dan navigasi layanan (terutama kasus kronis/kompleks), sering melibatkan koordinator kasus.
- **CHW (Community Health Worker / Kader kesehatan):** Anggota masyarakat terlatih yang membantu layanan promotif-preventif, penjangkauan, edukasi, dan dukungan kepatuhan pasien melalui jejaring komunitas.

- **Comprehensiveness (Komprehensif):** Cakupan layanan primer yang luas, dari promotif hingga rehabilitatif/paliatif sesuai kebutuhan pasien sepanjang daur hidup.
- **Continuity of care (Kesinambungan asuhan):** Keterhubungan layanan dari waktu ke waktu sehingga pasien tidak “terputus” dalam perawatan, baik di dalam fasilitas maupun antar tingkat layanan.
- **Coordination (Koordinasi):** Kemampuan layanan primer mengoordinasikan pelayanan antar program, antar profesi, dan antar fasilitas agar asuhan pasien tetap selaras.
- **Counter-referral / Rujuk balik:** Mekanisme pengembalian pasien dari fasilitas rujukan ke layanan primer dengan informasi klinis dan rencana tindak lanjut yang jelas agar asuhan berlanjut.

D

- **Dashboards/scorecards:** Ringkasan indikator kinerja (mis. mutu, cakupan, target) yang membantu evaluasi rutin dan perbaikan layanan.
- **Doctor shopping:** Perilaku pasien berpindah-pindah fasilitas/tenaga kesehatan untuk keluhan yang sama sehingga informasi klinis terfragmentasi dan kesinambungan melemah.
- **Determinants of health (Determinan kesehatan):** Faktor di luar layanan klinis (pendidikan, pekerjaan, lingkungan, sosial) yang memengaruhi status kesehatan, sehingga perlu jejaring lintas sektor.

E

- **Efisiensi sistem:** Kemampuan sistem kesehatan menghasilkan manfaat maksimal dengan sumber daya minimal melalui layanan primer yang kuat (mengurangi rujukan tak perlu, duplikasi, pemborosan).
- **Edukasi pasien:** Pemberian informasi yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti (obat, tanda bahaya, kontrol) untuk memperkuat self-care dan kepatuhan.

F

- **FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama):** Layanan tingkat pertama sebagai kontak awal masyarakat, termasuk Puskesmas dan fasilitas primer lain.
- **Follow-up (Tindak lanjut):** Pemantauan lanjutan setelah kunjungan/rujukan untuk memastikan terapi berjalan dan komplikasi dicegah.
- **4C:** Empat karakter layanan primer bermutu: *first-contact access, continuity, comprehensiveness, coordination*.

G

- **GERMAS:** Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pendekatan promotif-preventif berbasis perilaku dan lingkungan sehat.

H

- **Handover (Serah terima):** Proses pemindahan informasi dan tanggung jawab perawatan antar petugas/shift agar layanan aman dan tidak terjadi kehilangan informasi klinis.

- **Health literacy (Literasi kesehatan):** Kapasitas individu untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan untuk keputusan dan tindakan yang tepat.
- **Home care:** Layanan kesehatan di rumah pasien sebagai bagian penguatan akses dan kesinambungan (bila tersedia sesuai kebutuhan layanan primer).

I

- **ICT (Information and Communication Technology / TIK):** Teknologi (internet, perangkat, aplikasi) yang mendukung sistem informasi kesehatan dan pertukaran data layanan.
- **Indikator mutu:** Ukuran terpilih untuk menilai kinerja layanan (mis. kepatuhan SOP, waktu tunggu, kontrol PTM) sebagai dasar audit dan perbaikan.
- **Integrasi antar tingkat layanan:** Keterhubungan layanan primer–sekunder–tersier melalui rujukan dan rujuk balik yang berjalan baik.
- **Interoperabilitas:** Kemampuan sistem informasi berbeda untuk saling bertukar dan memakai data secara konsisten, sehingga rekam medis “mengalir” lintas layanan.

J

- **Jejaring layanan:** Keterhubungan layanan primer dengan unit/jejaring lain (Pustu, pusling, bidan desa, klinik, RS, laboratorium, apotek) untuk memperluas akses dan rujukan.

K

- **Kader/Posyandu:** Komponen komunitas yang membantu penjangkauan, edukasi, deteksi dini, dan dukungan program kesehatan berbasis masyarakat.
- **KIA (Kesehatan Ibu dan Anak):** Program layanan yang berfokus pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, termasuk pencegahan risiko dan promosi kesehatan.
- **Kolaborasi lintas sektor:** Kemitraan layanan primer dengan sektor non-kesehatan (pendidikan, desa/kelurahan, lingkungan, sosial) untuk memengaruhi determinan kesehatan.
- **Kuratif:** Layanan pengobatan untuk mengatasi penyakit/kondisi yang sudah terjadi.

L

- **LTFU (Lost to follow-up / Putus tindak lanjut):** Kondisi pasien tidak melanjutkan kontrol/terapi sesuai jadwal, sering terjadi pada penyakit kronis dan memperburuk luaran.
- **Logistik obat:** Rangkaian perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemantauan persediaan obat agar tersedia stabil.

M

- **Manajemen layanan:** Pengelolaan alur kerja, SDM, SOP, pemantauan mutu, dan koordinasi internal agar layanan konsisten dan efektif.
- **Multimorbiditas:** Keadaan pasien memiliki dua atau lebih penyakit kronis sekaligus, meningkatkan kompleksitas asuhan dan kebutuhan koordinasi.

- **Mutu layanan:** Tingkat kesesuaian pelayanan dengan standar/pedoman berbasis bukti serta kemampuan layanan menghasilkan luaran kesehatan yang diharapkan.

O

- **Obat esensial:** Daftar obat prioritas yang seharusnya selalu tersedia karena paling dibutuhkan, efektif, aman, dan cost-effective.
- **One day care:** Pelayanan yang selesai dalam satu hari tanpa rawat inap panjang (bila diadopsi dalam layanan primer tertentu).

P

- **Paliatif:** Layanan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius melalui pengendalian gejala, dukungan psikososial, dan pendampingan.
- **Pasien kronis:** Pasien dengan kondisi jangka panjang (mis. hipertensi, diabetes) yang memerlukan kontrol rutin dan monitoring berkelanjutan.
- **PHC (Primary Health Care / Pelayanan Kesehatan Primer):** Pelayanan tingkat pertama yang menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara aksesibel, komprehensif, dan berkesinambungan.
- **Polifarmasi:** Penggunaan banyak obat dalam satu waktu (umumnya pada pasien kronis/multimorbid) yang meningkatkan risiko interaksi obat dan medication error.
- **Preventif:** Upaya pencegahan penyakit, termasuk skrining, imunisasi, konseling, dan intervensi faktor risiko.

- **Promotif:** Upaya peningkatan kesehatan melalui edukasi, pemberdayaan, dan penciptaan lingkungan/perilaku sehat.
- **Puskesmas:** Fasilitas kesehatan primer yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan penekanan promotif-preventif di wilayah kerja.
- **Program vertikal:** Program yang berjalan terpisah per isu/penyakit (mis. TB, gizi, KIA) sehingga koordinasi lintas unit bisa menantang jika tidak diintegrasikan.

R

- **Rehabilitatif:** Layanan pemulihan fungsi dan kualitas hidup setelah sakit atau cedera.
- **Rekam medis terintegrasi:** Pencatatan informasi pasien yang konsisten dan tidak terfragmentasi antar unit/petugas, mendukung kesinambungan informasional.
- **Rujukan:** Pengalihan pasien dari layanan primer ke layanan yang lebih mampu (sekunder/tersier) ketika kebutuhan melebihi kapasitas primer.

S

- **SBAR:** Format komunikasi terstruktur (*Situation–Background–Assessment–Recommendation*) untuk serah terima/eskalasi klinis agar informasi tidak hilang dan keputusan lebih aman.
- **SDGs (Sustainable Development Goals):** Target pembangunan global, termasuk tujuan kesehatan (SDG 3) yang mendorong penguatan layanan primer menuju UHC.

- **SDM kesehatan:** Tenaga kesehatan dan kompetensinya (jumlah, distribusi, skill mix) sebagai prasyarat layanan primer yang komprehensif.
- **Self-care / self-management:** Kemampuan pasien mengelola kesehatan dan penyakitnya (obat, gaya hidup, monitoring) dengan dukungan layanan.
- **SOP (Standard Operating Procedure / Prosedur Operasional Baku):** Dokumen standar langkah kerja layanan untuk memastikan praktik seragam dan aman.

T

- **Task shifting / task sharing (Alih tugas / berbagi tugas):** Pengalihan atau pembagian tugas klinis tertentu ke profesi lain dengan pelatihan dan regulasi, untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- **Team-based care:** Pelayanan berbasis tim multiprofesi dengan pembagian peran jelas agar layanan lebih terkoordinasi dan berkesinambungan.
- **TB (Tuberkulosis):** Penyakit infeksi menular yang memerlukan deteksi dini, pengobatan teratur, dukungan kepatuhan, serta pendekatan anti-stigma di komunitas.
- **Time-and-motion study:** Metode penelitian untuk mengukur alokasi waktu kerja (mis. waktu klinis vs dokumentasi) guna menilai beban kerja dan efisiensi layanan.

U

- **UHC (Universal Health Coverage / Cakupan Kesehatan Semesta):** Kondisi semua orang memperoleh layanan kesehatan bermutu yang

dibutuhkan tanpa kesulitan finansial; layanan primer menjadi fondasinya.

- **UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat):** Pelayanan kesehatan berbasis populasi/komunitas (promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan, dll.).
- **UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan):** Pelayanan kesehatan berbasis individu (mis. rawat jalan, gawat darurat, layanan klinis individual) di layanan primer.

W

- **WUS (Wanita Usia Subur):** Perempuan pada rentang usia reproduktif yang menjadi sasaran penting program kesehatan reproduksi/KIA.

PROFIL PENULIS



Bd. Yohana Suganda, S.ST., M.Keb., Lahir di Sungai Limau, 03 Juli 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Kebidanan, Universitas Andalas tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sebagai dosen dengan lulusan DIV bidan pendidik dan melanjutkan pendidikan pada s2 kebidanan pada tahun 2014 dan bekerja pada Universitas Sumatera Barat hingga sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sumatera Barat mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan, Asuhan Persalinan, Komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan BBL. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yohanaaldhitya@gmail.com
Motto: "Menjadi Jembatan Ilmu untuk Asuhan yang Berkesinambungan dan Berkemanusiaan."



PROFIL PENULIS



Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep., Lahir di Bandung, 21 November 1980 Pendidikan Diploma III Lulus Tahun 2002. Sarjana 2016 lanjut Ners 2018 dan magister Keperawatan Tahun 2020 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 Sebagai Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Serang lanjut Tahun 2012 Sebagai tenaga laboran dilaboratorium Keperawatan Pemerintah Kabupaten Serang dan Tahun 2021 Sebagai Tenaga Pengajar di Diploma III Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai melalui e-mail:hesti_321@untirta.ac.id
Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An., Lahir di Banda Aceh, 27 April 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun

2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Keperawatan Anak, lulus tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan Ners Spesialis Keperawatan Anak, lulus tahun 2010 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Penulis juga aktif sebagai Ners Spesialis Keperawatan Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Penulis berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan organisasi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Wilayah Aceh. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriintan@usk.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Bd. Peny Ariani, SST., M.Keb., Lahir di Marjanji, 14 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun pada tahun 2015, serta Pendidikan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas Padang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sampai saat ini dan saat ini penulis mengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan, Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas dan Menyusui, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia serta Asuhan Kebidanan berbasis Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti bidang ASI, kebijakan kesehatan dan masa nifas, publikasi, seminar, bidang pelatihan dan Ketua Dewan redaksi ejournal delihusada, serta konselor menyusui aktif. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: penyariani@gmail.com
Motto: "Together we Can, Together we Growth"

Sinopsi

Bunga rampai “**Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan dalam Praktik Tenaga Kesehatan**” menghadirkan pembahasan komprehensif tentang pentingnya layanan kesehatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan individu sepanjang daur kehidupan. Buku ini menekankan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kesinambungan asuhan, koordinasi antarprofesi, serta kemampuan tenaga kesehatan menjangkau kebutuhan pasien pada berbagai fase dan konteks pelayanan.

Bab pertama menguraikan **konsep pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan (continuum of care)** sebagai fondasi penguatan sistem layanan—mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif—dengan alur rujukan yang jelas dan kolaborasi lintas fasilitas. Pembaca diajak memahami bagaimana integrasi layanan dapat meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi, dan mutu pelayanan secara menyeluruh.

Bab selanjutnya menyoroti isu penting dalam kesehatan reproduksi dan literasi kesehatan, yaitu **pemetaan kebutuhan informasi kesehatan wanita sub remaja serta platform yang sering digunakan**. Pembahasan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan

edukasi yang sesuai usia dan konteks sosial, sekaligus memanfaatkan media digital secara tepat agar informasi yang diterima remaja akurat, aman, dan mampu mendorong perilaku sehat.

Pada bagian berikutnya, buku ini menegaskan **peran perawat dalam asuhan keperawatan holistik** sebagai penguat kesinambungan layanan. Perawat diposisikan bukan hanya pelaksana tindakan, tetapi juga pengkaji kebutuhan menyeluruh pasien, penghubung antar layanan, pendidik kesehatan, serta pendamping yang memastikan asuhan tetap konsisten dan manusiawi di berbagai tatanan pelayanan.

Sebagai penutup, bunga rampai ini membahas **tantangan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer**, termasuk keterbatasan sumber daya, beban kerja, hambatan sistem rujukan, ketimpangan akses, hingga kebutuhan penguatan manajemen dan kolaborasi lintas sektor. Pembahasan ini memberi perspektif realistis sekaligus menawarkan arah perbaikan agar pelayanan primer mampu menjadi garda terdepan layanan terpadu.

Dengan bahasa yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan, buku ini ditujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, akademisi, dan pengelola layanan kesehatan sebagai referensi untuk memperkuat praktik pelayanan yang terkoordinasi, holistik, dan

berkesinambungan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bunga rampai “Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Berkesinambungan dalam Praktik Tenaga Kesehatan” menghadirkan pembahasan komprehensif tentang pentingnya layanan kesehatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan individu sepanjang daur kehidupan. Buku ini menekankan bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kesinambungan asuhan, koordinasi antarprofesi, serta kemampuan tenaga kesehatan menjangkau kebutuhan pasien pada berbagai fase dan konteks pelayanan.

Bab pertama menguraikan konsep pelayanan kesehatan terpadu dan berkesinambungan (continuum of care) sebagai fondasi penguatan sistem layanan—mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif—dengan alur rujukan yang jelas dan kolaborasi lintas fasilitas. Pembaca diajak memahami bagaimana integrasi layanan dapat meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi, dan mutu pelayanan secara menyeluruh.

Bab selanjutnya menyoroti isu penting dalam kesehatan reproduksi dan literasi kesehatan, yaitu pemetaan kebutuhan informasi kesehatan wanita sub remaja serta platform yang sering digunakan. Pembahasan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan edukasi yang sesuai usia dan konteks sosial, sekaligus memanfaatkan media digital secara tepat agar informasi yang diterima remaja akurat, aman, dan mampu mendorong perilaku sehat.

Pada bagian berikutnya, buku ini menegaskan peran perawat dalam asuhan keperawatan holistik sebagai penguat kesinambungan layanan. Perawat diposisikan bukan hanya pelaksana tindakan, tetapi juga pengkaji kebutuhan menyeluruh pasien, penghubung antar layanan, pendidik kesehatan, serta pendamping yang memastikan asuhan tetap konsisten dan manusiawi di berbagai tatanan pelayanan.

Sebagai penutup, bunga rampai ini membahas tantangan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer, termasuk keterbatasan sumber daya, beban kerja, hambatan sistem rujukan, ketimpangan akses, hingga kebutuhan penguatan manajemen dan kolaborasi lintas sektor. Pembahasan ini memberi perspektif realistis sekaligus menawarkan arah perbaikan agar pelayanan primer mampu menjadi garda terdepan layanan terpadu.

Dengan bahasa yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan, buku ini ditujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, akademisi, dan pengelola layanan kesehatan sebagai referensi untuk memperkuat praktik pelayanan yang terkoordinasi, holistik, dan berkesinambungan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

ISBN 978-634-7556-89-9 (PDF)



9

786347

556899

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

